



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN KINERJA TAHUNAN KOMITE PPI TAHUN 2025

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, maka rumah sakit harus melakukan upaya peningkatan mutu dan pelayanan medic baik melalui akreditasi, sertifikasi, ataupun proses peningkatan mutu lainnya.

Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitatif (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

HAIs adalah infeksi yang terjadi pada pasien dimana pada waktu dirumah belum terjadi proses infeksi dan baru muncul saat dilakukan perawatan di Rumah sakit atau infeksi yang terjadi pada tenaga kesehatan. Infeksi Rumah Sakit (IRS) atau HAIs (*Health-care Associated infections*) merupakan masalah serius yang harus dicegah dan dikendalikan sebaik-baiknya. Angka kejadian HAIs terus meningkat antara 1-40% yang berdampak pada peningkatan lama rawat (LOS), biaya perawatan dan resiko morbiditas dan mortalitas. Angka kejadian HAIs meningkat sampai 40% di Asia, Amerika Latin dan Afrika. Oleh karena itu *World Health Organization* (WHO) melalui gerakan *global patient safety challenge* menekankan pentingnya program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI). Komite PPI adalah komite yang bertugas untuk mencegah terjadinya Hais di Rumah sakit.

Kejadian infeksi ini dapat menghambat proses penyembuhan dan pemulihan pasien bahkan dapat menimbulkan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan memperpanjang lama hari rawat, sehingga biaya meningkat dan akhirnya mutu pelayanan di sarana kesehatan akan menurun. Tak dipungkiri lagi untuk masa yang akan datang dapat timbul tuntutan hukum bagi sarana pelayanan kesehatan.

Oleh karena hal tersebut diatas maka Komite PPI Rumah Sakit wajib melakukan pemantauan segala aktivitas kegiatan yang dilakukan di Rumah Sakit. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data, tabulasi data, Analisa, serta penyajian data. Hasil kegiatan akan dituangkan dalam bentuk laporan baik laporan bulanan, triwulan, maupun laporan tahunan. Laporan akan disampaikan kepada direktur serta komite lain diharapkan adanya feedback terhadap laporan yang disampaikan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

-
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;

1.3 Tujuan

Tujuan pelaporan kegiatan PPI adalah:

1. Memberikan gambaran mutu pelayanan kepada pihak manajemen rumah sakit.
2. Mengidentifikasi masalah yang ada di unit kerja serta lingkungan rumah sakit.
3. Memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen hal-hal yang membutuhkan perbaikan sesuai pedoman PPI.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

2.3 Motto

“Sahabat Menuju Sehat”

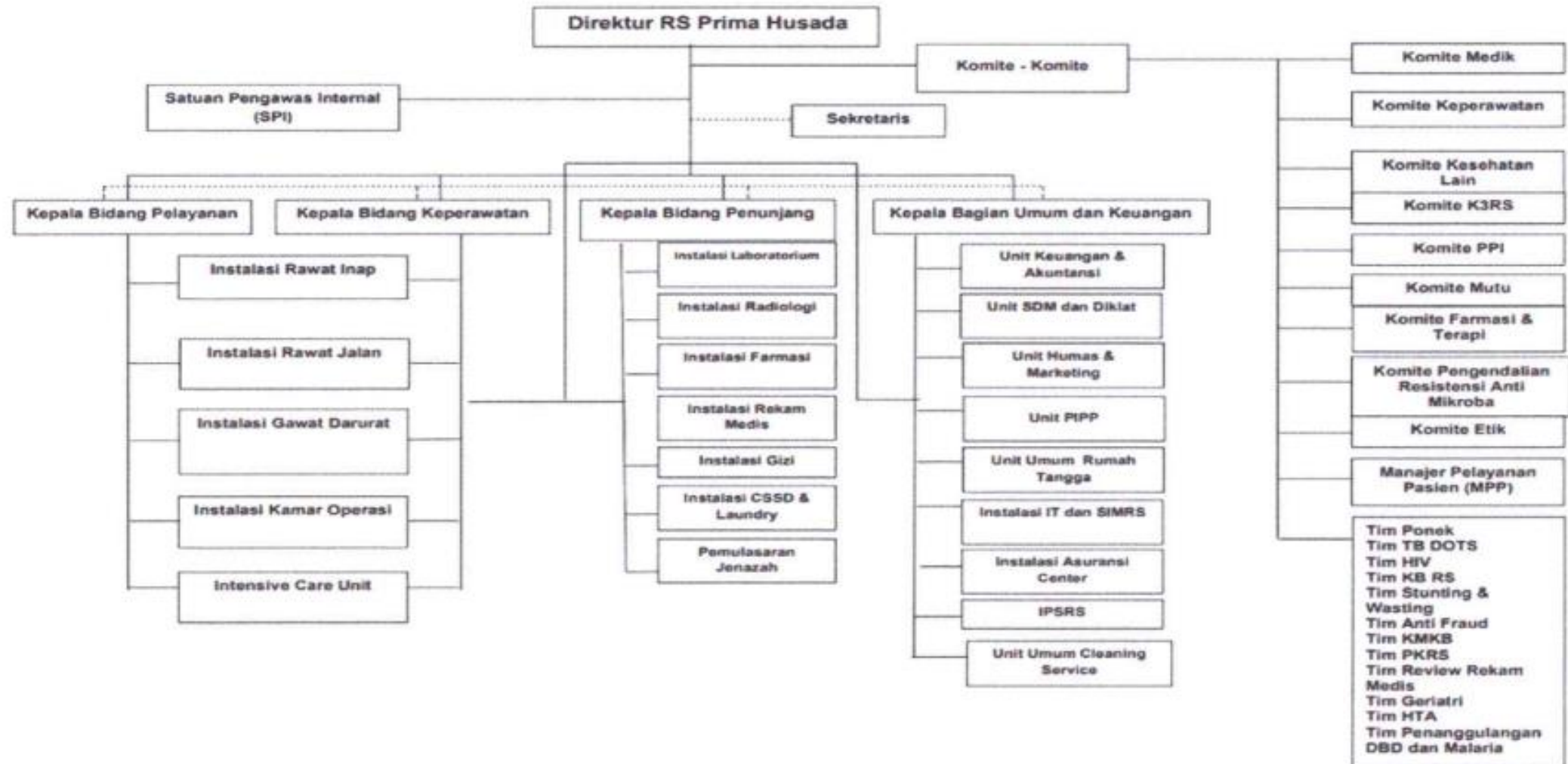
2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

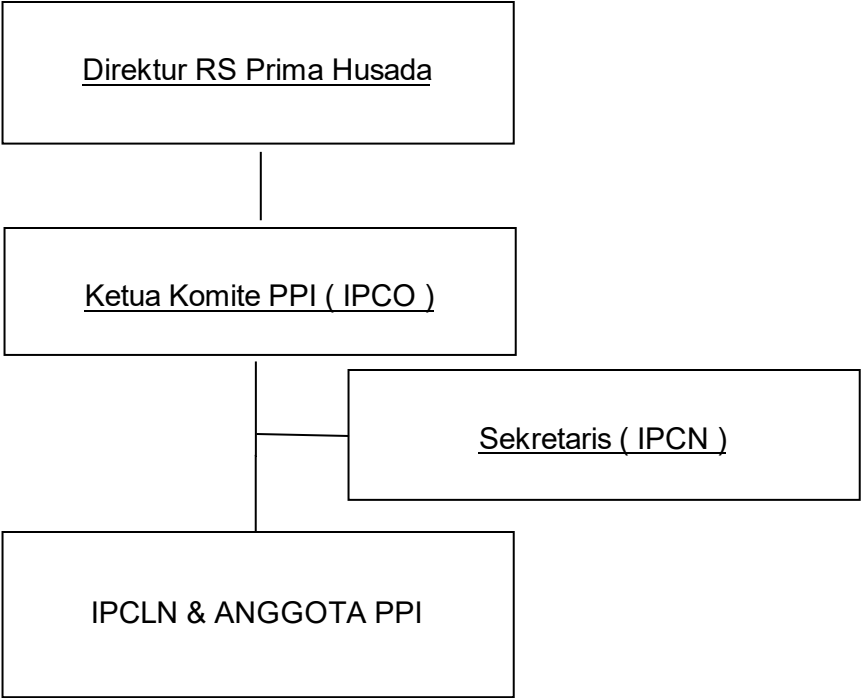
1. Jujur dan dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK

Gambar 2.5.1 Struktur Organisasi Tata Kelola RS Prima Husada



Gambar 2.5.2 Struktur Organisasi Komite PPI RS Prima Husada



BAB III
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 SDM

3.1.1 Ketenagaan (Distribusi, kualifikasi, dan kebutuhan tenaga)

Tabel 3.1.1 Ketenagaan (Distribusi, kualifikasi, dan kebutuhan tenaga)

Jabatan	Pendidikan		Sertifikasi				Jumlah SDM			Keterangan
	Standar	2025	PPI Dasar	PPI Lanjut	IPCN	IPCN Lanjut	Standar	2024	Kebutuhan	
IPCO	Dokter	Dokter	1/1	-	-	-	1	1	0	
IPCN	S1 Kep	S1 Kep	1/1	-	1/1	-	1	1	0	1 purna waktu
IPCLN	S1/D3 Kep	S1 & D3 Kep	17/17	-	-	-	17	17	0	- Merangkap fungsi pelayanan. - 2 dari 14 IPCLN sudah PPI Dasar Eksternal.
Maternitas	S1/D3	D3 Keb	1/1	-	-	-	1	1	0	
Gizi	S1/D3	D3 Gz	1/1	-	-	-	1	1	0	
IPSRS & K3RS	S1/D3	S1 SKM	1/1	-	-	-	1	1	0	
CSSD	SMA	D3 Kep	1/1	-	-	-	1	1	0	
Laundry	SMA	SMA	1/1	-	-	-	1	1	0	
Cleaning Service	SMA	SMA	1/1	-	-	-	1	1	0	
Petugas Kamar Jenazah	SMA	SMA	1/1	-	-	-	1	1	0	
Laboratorium	S1/D3	D3 Ak	1/1	-	-	-	1	1	0	
IFRS	S1/D3	S1 Apt	1/1	-	-	-	1	1	0	
Instalasi RM	S1/D3	D3 RMIK	1/1	-	-	-	1	1	0	
Asuransi Center	S1/D3	D3 RMIK	1/1	-	-	-	1	1	0	
Radiologi	S1/D3	D3 Rad	1/1	-	-	-	1	1	0	

Evaluasi tahun 2025 terkait SDM Komite PPI:

- April 2025 terdapat penambahan anggota Komite PPI pada unit Farmasi karena dibagi tugas untuk yang pelayanan di depo farmasi dan pelayanan pada Gudang farmasi.
- Dilakukan perubahan pada SK Komite PPI dan SK IPCLN terkait perubahan yang dilakukan.

3.1.2 Orientasi

- Orientasi petugas/karyawan baru tentang PPI

Evaluasi:

- a. Dilakukan orientasi umum pada 3 orang petugas Primantara (pengantaran obat) dengan materi terkait kebersihan tangan dan etika batuk serta pemakaian APD pada 31 Juli 2025. Peserta dapat mempraktekkan 6 langkah cuci tangan dengan baik.
- b. Dilakukan orientasi umum dengan materi PPI pada 1 orang perawat gigi baru dan petugas parkir baru pada tanggal 28 Oktober 2025. Dari 2 profesi ada yang kurang memahami dari materi yang diberikan seperti petugas parkir karena ilmu baru bagi mereka, namun pada saat dicoba untuk praktek beberapa dapat mempraktekkan terkait kebersihan tangan dengan baik meskipun belum lancar.

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan

1) Pelatihan internal tentang PPI Dasar.

Evaluasi:

- Diklat Internal PPI dasar sudah dilakukan pada 21 - 22 Mei 2025, dari hasil evaluasi diperoleh:
 - Jumlah kehadiran sebanyak 320 orang atau sekitar 81,63% dari jumlah undangan. Tidak hadir sebanyak 69 orang dari total undangan.
 - Ringkasan hasil pre-test:
 - Nilai Sangat Baik (poin 96 - 100) : 51 orang atau 15,94%
 - Nilai Baik (poin 80 - 95) : 117 orang atau 36,56%
 - Nilai Cukup (poin 50 - 79) : 116 orang atau 36,25%
 - Nilai Kurang (poin <50) : 26 orang atau 8,13%
 - Tidak mengerjakan : 10 orang atau 3,12%
 - Ringkasan hasil post-test:
 - Nilai Sangat Baik (poin 96 - 100) : 188 orang atau 58,75%
 - Nilai Baik (poin 80 - 95) : 126 orang atau 39,37%
 - Nilai Cukup (poin 50 - 79) : 3 orang atau 0,94%
 - Nilai Kurang (poin <50) : 0 orang atau 0%
 - Tidak mengerjakan : 3 orang atau 0,94%

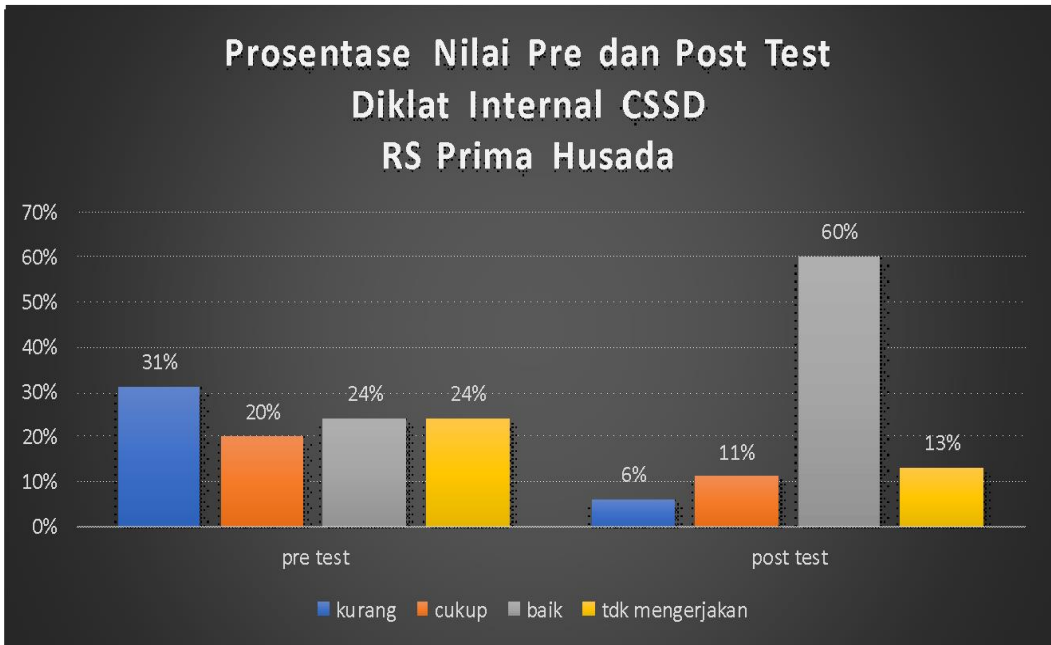
Dari kesimpulan hasil pre test dan post test diatas, dapat dilihat bahwa setelah dilakukan pelatihan, nilai post test mengalami peningkatan dari hasil nilai pre test, namun masih diperoleh sedikit petugas yang masih belum terlalu paham karena hasil pre testnya belum cukup baik dan 3 orang tidak mengerjakan.

Keseluruhan peserta dapat menangkap materi yang disampaikan oleh pemateri dengan baik.

- 2) Pada bulan Agustus 2025, Komite PPI ikut bergabung dengan Pokja Komunikasi Efektif memberikat diklat internal dengan metode pitstop dengan materi yang mengacu pada standar akreditasi PPI 13, bulan ini dilakukan pada petugas perawat dan bidan. Evaluasi dari hasil diklat ini, petugas dari unit perawatan cukup baik berkomunikasi untuk memberikan edukasi sesuai prinsip komunikasi (terutama memang sehari-hari sering berhadapan dengan pasien untuk edukasi), terkait dengan materi yang harus diedukasikan mayoritas

- paham seperti prinsip etika batuk, 5 momen cuci tangan dan 6 langkah cuci tangan walaupun harus mengurut satu per satu perlahan langkahnya.
- 3) Inhouse training terkait proses sterilisasi.
- Evaluasi:

- In house training terkait sterilisasi sudah dilakukan pada tahun ini, in house training dilakukan pada bulan 19 Mei 2025 dengan sasaran seluruh petugas CSSD dan perwakilan unit pelayanan dengan pemateri berasal dari vendor pihak ke 3 yang paham terkait sterilisasi. Dengan ringkasan hasil:
 - Jumlah kehadiran sebanyak 40 orang (bukan termasuk pemateri) atau sekitar 89% dari jumlah undangan.
 - Dengan keterangan 2 orang ijin kepentingan RS di luar dan 3 orang tanpa keterangan.
 - Gambar 1.3 Grafik Nilai Pre & Post Test In House Training CSSD



- 4) Pendidikan berkelanjutan.
- Evaluasi: Pelatihan eksternal tentang PPI Dasar oleh IPCLN belum terlaksana pada tahun ini, hanya saja mengikuti seminar/workshop online pada:
- Tanggal 30 Agustus 2025, webinar nasional digitalisasi logbook IPCN: meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kepatuhan dalam program PPI.
 - Tanggal 15 Oktober 2025, Seminar hand hygiene as culture: transformasi budaya kebersihan tangan dari regulasi menuju perilaku sehari-hari di rumah sakit.
 - Tanggal 15 Oktober 2025, webinar nasional cuci tangan pakai sabun tahun 2025.
- 5) Sosialisasi terkait PPI kepada petugas.
- Evaluasi: Sosialisasi kepada seluruh petugas terlaksana dengan dibantu oleh para IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. Pada bulan Januari-Desember 2025 sosialisasi antar staf didokumentasikan dengan baik dengan total capaian 432 orang petugas dengan system dapat berulang pada petugas yang sama.

3.1.4 Evaluasi Kinerja Staf

IPCLN dan anggota komite PPI lainnya secara keseluruhan sudah menjalankan tugasnya, namun masih ada beberapa petugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik setiap bulannya dan menunggu ditegur terlebih dahulu.

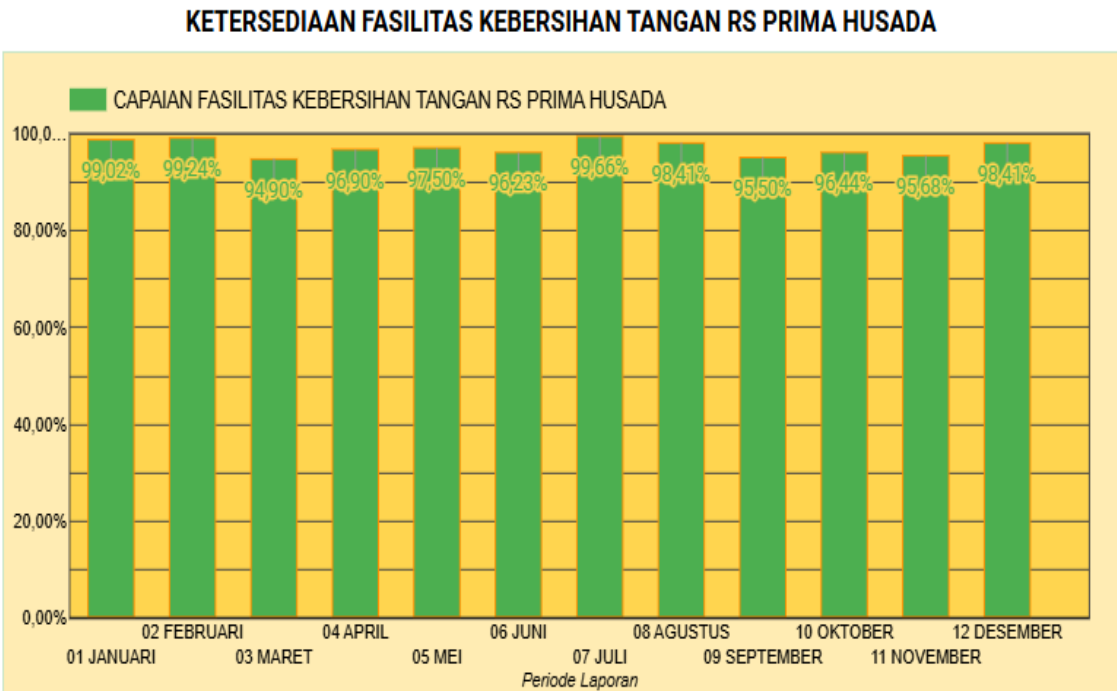
Tabel 3.1.4 Evaluasi kinerja IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya tahun 2025

3.3 Kinerja Produktifitas

3.3.1 Kewaspadaan Standar

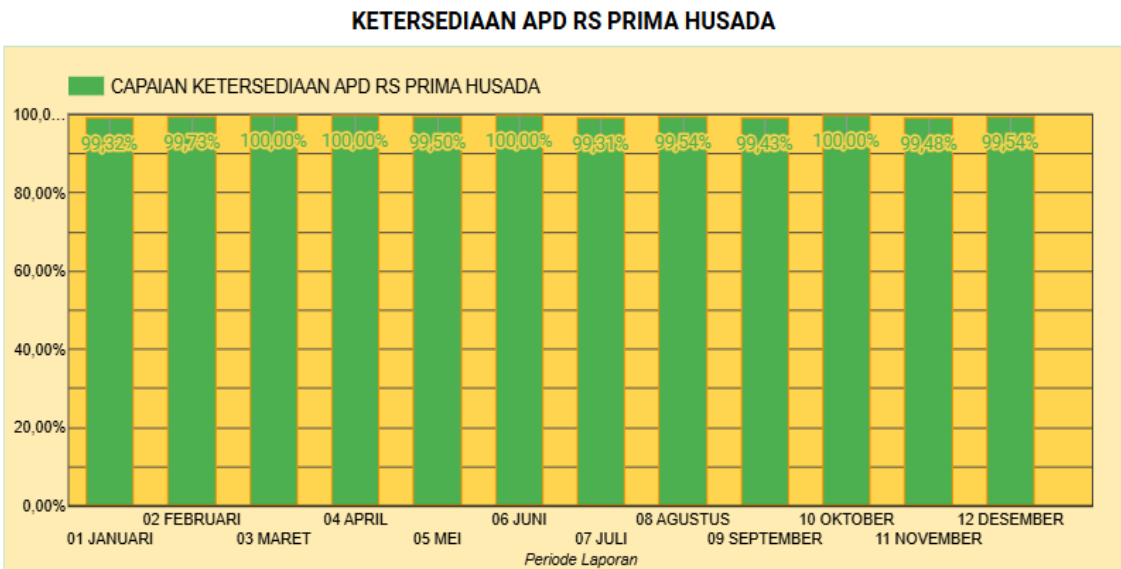
1) Fasilitas kebersihan tangan.

Gambar 3.3.1.1 Grafik Ketersediaan Fasilitas Kebersihan Tangan RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



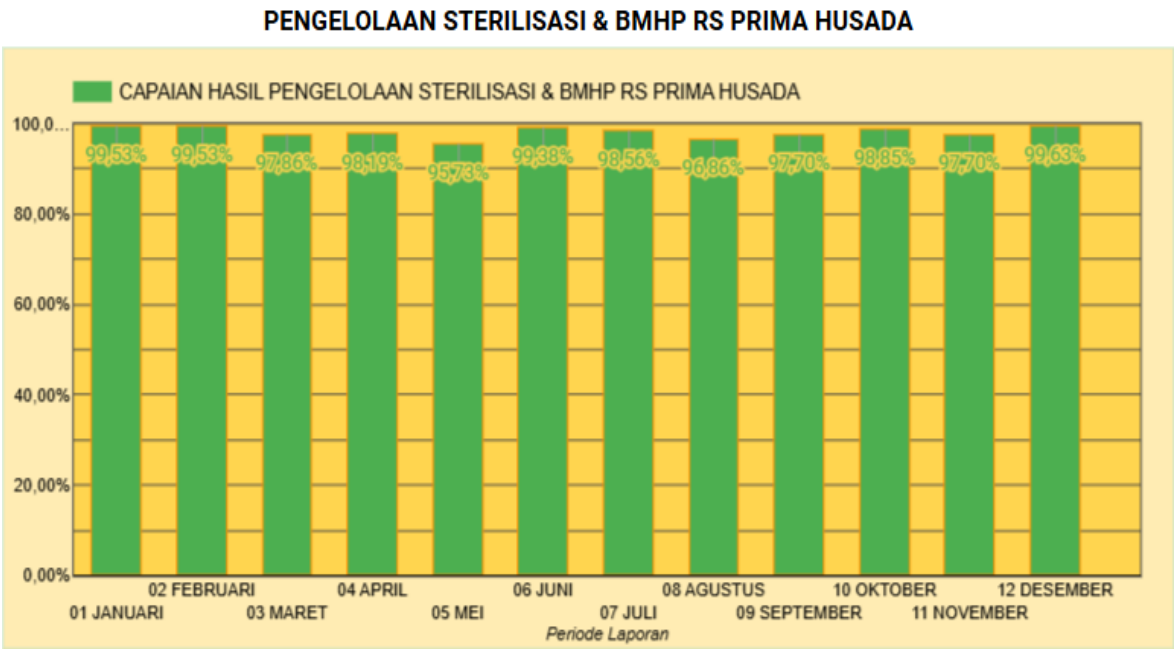
Analisa:	Fasilitas kebersihan tangan sudah dilakukan perbaikan dan pemenuhan kelengkapannya. Namun masih ditemukan stiker HH yang mulai pudar/rusak pada bed pasien maupun di wastafel ruangan. Selain itu, botol handsoap ditemukan tidak ada diatas wastafel dan harus konfirmasi pada petugas terlebih dahulu karena dipakai untuk didalam toilet. Bed pasien yang baru juga ada yang belum terpasang stiker HH dan handrub, namun setelah diingatkan petugas sudah menambahkan kembali.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan capaian dan monitoring ketersediaan fasilitas kebersihan tangan di unit. • Ajak petugas unit terkait untuk juga peduli pada fasilitas di unitnya masing-masing dengan melaporkan jika ada fasilitas cuci tangan yang kurang atau rusak. • Koordinasi dengan petugas tim umum untuk melakukan cek isi handrub pada saat membersihkan ruangan, atau dengan kontrol oleh perawat ruangan masing-masing. • Mengajukan ulang terkait tatakan handrub yang kurang.

- 2) Ketersediaan APD di unit.
- Gambar 3.3.1.2 Grafik Ketersediaan APD di Unit RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Analisa:	Ketersediaan APD di unit-unit sudah baik dengan kolaborasi control dari farmasi sebagai penyedia, hanya saja terkait APD di unit kadang penggunaannya tidak sesuai seperti CS yang memakai handscoon bedah saat membersihkan ruangan atau nakes yang tidak menggunakan APD sesuai jenis penyakit dan tindakan yang dilakukan.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan capaian dan monitoring ketersediaan APD di unit agar tidak sampai menimbun atau kehabisan APD.

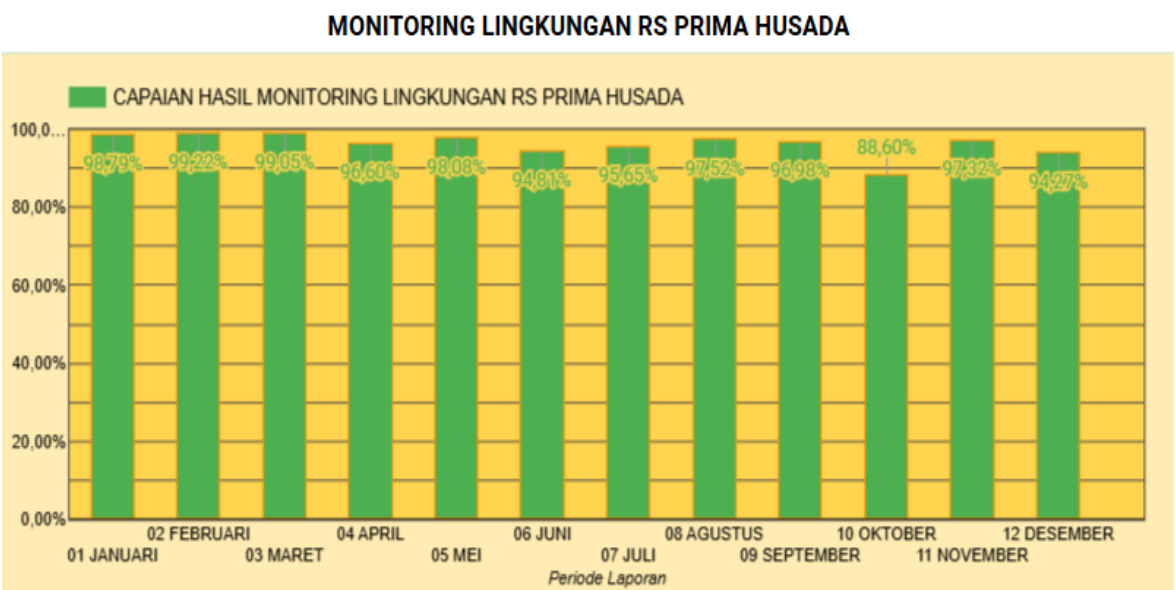
- 3) Pengelolaan sterilisasi dan BMHP
- Gambar 3.3.1.3 Grafik Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP Di CSSD RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Analisa:	Capaian penanganan dan pengiriman sampah di ruangan berada pada kisaran 95,73% - 99,63%. Penyeterilan alat sudah tersentral di CCSD, proses sterilisasi juga sudah dilakukan dengan baik, hanya saja kebersihan ruang CSSD perlu ditingkatkan dan kebiasaan petugas CSSD untuk menutup kembali pintu pencucian kotor, dan untuk
----------	---

	petugas unit untuk lebih tertib lagi menyetorkan alat kotor langsung ke CSSD dengan menggunakan box alat kotor. Selain itu, stiker indikator steril juga ada yang tidak berfungsi pada saat digunakan pada mesin non steamer.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan capaian dan melakukan koordinasi dengan Karu unit pelayanan untuk menjalankan pelayanan CSSD sesuai standar. • Meningkatkan monitoring dan pelaporan isidentil harian jika ada temuan khusus. • Mengingatkan kembali petugas unit yang tidak langsung menyerahkan alat kotor & memberikan edukasi ulang apabila tidak langsung dikembalikan, setidaknya alat harus dalam posisi sudah dibilas air mengalir di spoelhoek unit untuk mencegah korosif. • Mengingatkan petugas CSSD untuk menertibkan petugas unit yang membawa alat kotor wajib menggunakan box alat kotor. • Monitoring petugas CSSD untuk membersihkan box alat secara menyeluruh.

4) Pengendalian infeksi lingkungan
 Gambar 3.3.1.4 Grafik Pengendalian Infeksi Lingkungan RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025

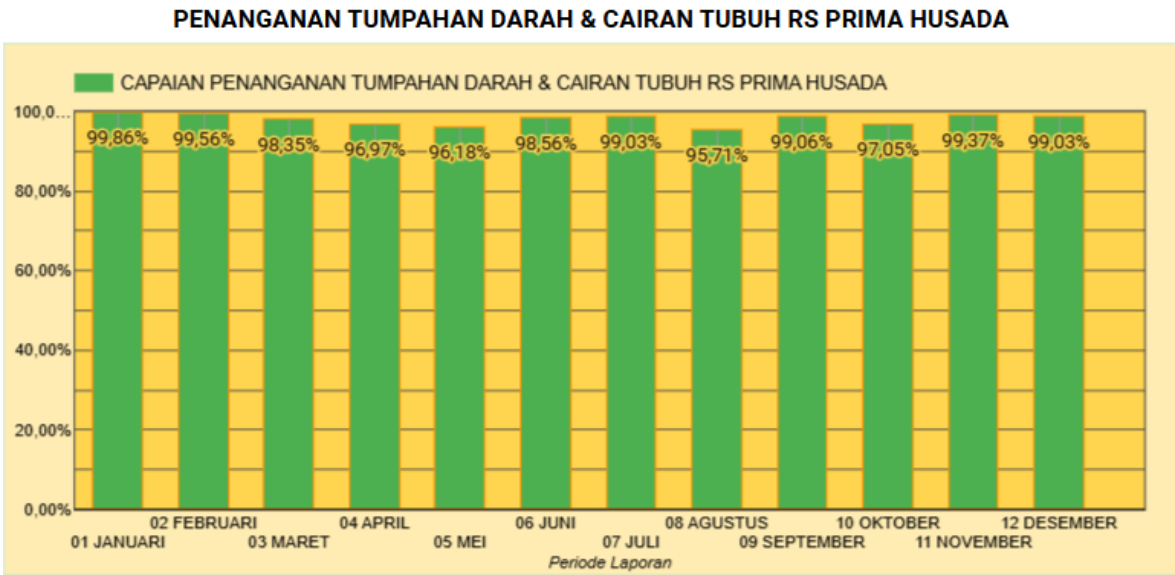


Analisa:	Hasil angka kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan rentang prosentasenya 88,60% - 99,22% dengan rata-rata capaian 96-97%. Artinya standar kebersihan dan control lingkungan masih tergolong baik. Terjadinya penurunan pada pertengahan akhir tahun sering terjadi dikarenakan peningkatan jumlah kunjungan, peningkatan beban kerja CS, dan adanya lembur pembersihan/pergantian petugas. Masih perlu ditingkatkan kembali karena masih banyak ditemukan unit-unit yang petugasnya kurang menjaga kebersihan unitnya dan masih harus terus diingatkan, terutama kebersihan dinding/area bed, troli Tindakan, troli injeksi dan alat medis dan unit yang dekat jalan karena resiko berdebu sangat tinggi.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan capaian dan melakukan koordinasi dengan Karu dan tim CS untuk menjaga lingkungan tempat kerja nya selalu bersih dan rapi. • Koordinasi dengan CS untuk membersihkan area bed head pasien rutin terutama pada saat pasien pulang dan area sudut-sudut ruang.

	Tegur dan mengajarkan bagaimana proses pembersihan yang seharusnya saat pasien pulang. • Mengingatkan petugas untuk segera memindahkan barang yang diletakkan tidak sesuai tempatnya. • Menyampaikan pada kepala ruang untuk lebih memperhatikan ruangnya. • Peningkatan supervise ditingkat cleaning service sendiri dengan mengoptimalkan pengisian ceklist harian kebersihan. • Monitoring penggunaan desinfektan pada unit khusus. (IKO, Isolasi, ICU, IRNA)
--	--

5) Penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh

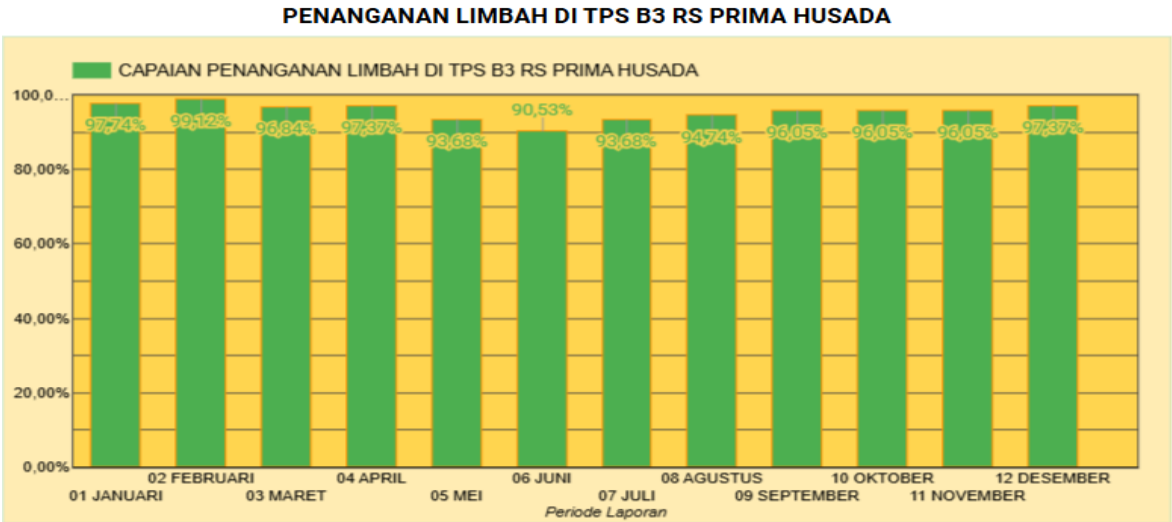
Gambar 3.3.1.5 Grafik Penanganan Tumpahan Darah dan Cairan Tubuh RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Analisa:	Penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh masih mengalami penurunan pada akhir tahun ini. Capaiannya berkisar antara 95,71% - 99,86%. Penggunaan spill kit perlu lebih ditekankan lagi untuk menangani adanya tumpahan darah atau cairan tubuh. Beberapa unit masih ditemukan tidak tertib untuk mengisi ulang kelengkapan spill kit unitnya.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan supervise di unit, dan ajak kepala unit untuk melihat ketidak patuhan yang terjadi di unitnya dan agar segera menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut. • PIC unit dan Karu perlu melakukan kontrol terhadap kelengkapan isi spill kit dan kepatuhan penggunaannya karena merupakan tanggung jawab dari unit masing-masing. Terutama terkait kelengkapan APD seperti apron, masker, dan nurse cap karena petugas nakes lebih banyak lepas tangan dan melimpahkan tanggung jawab kelengkapannya pada CS. • Mengingatkan petugas terkait dan menyampaikan kepada kepala ruang terkait ketidaksesuaian dengan standar. • Mengingatkan kembali terutama petugas CS pada saat membersihkan ruangan tidak boleh hanya pada daerah yang kelihatan mata saja, tetapi daerah yang tidak terjangkau juga wajib dibersihkan.

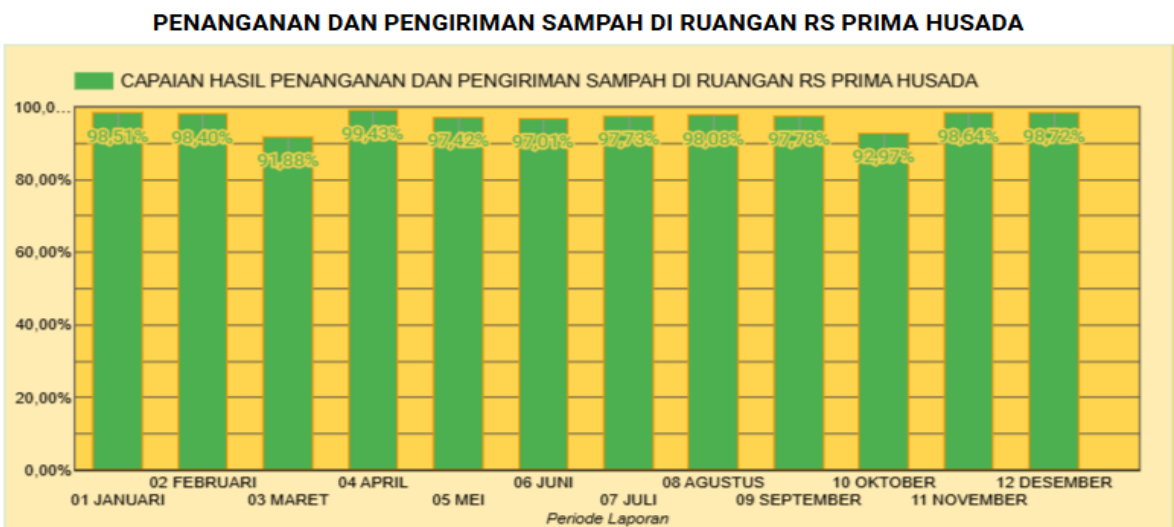
	Meminta petugas unit untuk melengkapi saat itu juga box spill kit yang tidak lengkap dan meminta petugas untuk memberikan contoh pemakaian spill kit yang benar.
--	--

6) Pengelolaan limbah infeksius Rumah Sakit (TPS B3)
 Gambar 3.3.1.6 Pengelolaan Limbah Infeksius (TPS B3) RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



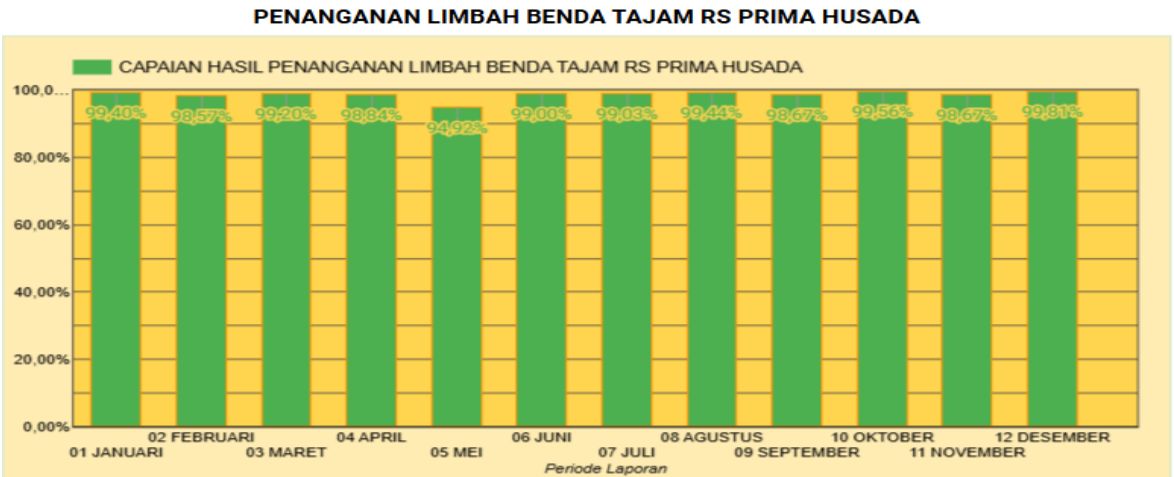
Analisa:	- Capaian penanganan limbah B3 berada pada kisaran 90,53% - 99,12%. Capaiannya mengindikasikan bahwa pengelolaan limbah di TPS B3 sudah berjalan baik. - Bulan Juni 2025 terdapat capaian terendah 90,53%, kemungkinan penyebab diantaranya: adanya peningkatan volume limbah B3, kepatuhan petugas yang tidak konsisten, dan keterbatasan fasilitas/area di TPS B3. - TPS B3 sudah jarang sekali berbau, terutama di bagian paling dalam (area bak botol infus), karena petugas CS sudah rutin melakukan pembersihan di TPS B3, namun petugas terkadang masih didapatkan tidak menyalakan exhaust fan. - Penataan tumpukan sampah sudah dilakukan dengan baik karena sudah disediakan tong-tong penampung sampah sesuai jenis sampahnya supaya peletakkan sampah terlihat rapi. Namun terkadang petugas masih tidak tertib menumpuk sampah di salah satu tong saja yang dekat dengan pintu.
Tindak Lanjut:	- Tingkatkan capaian dan lakukan audit supervisi berkala di area TPS B3. - Lakukan monitoring dan evaluasi rutin. Menggunakan ceklist standar untuk mendeteksi potensi ketidaksesuaian. - Meminta bantuan pada petugas CS untuk tetap melakukan proses pembersihan TPS B3 rutin terutama setelah dilakukan pengambilan sampah oleh pihak 3 atau saat kondisi TPS B3 kosong/minimal sampah. - Koordinasi dengan pihak ke-3 untuk evaluasi waktu pengambilan sampah. - Kolaborasi dengan Karu CS untuk ketertiban pencatatan di TPS B3. - Monitoring petugas CS yang tidak memasukkan sampah infeksius pada bak sampah yang sudah disediakan di TPS B3. - Monitor peletakkan sampah di dalam tong sampah di TPS B3.

7) Penanganan dan pengiriman sampah di ruangan
Gambar 3.3.1.7 Grafik Penanganan dan Pengiriman Sampah Di Ruangan RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



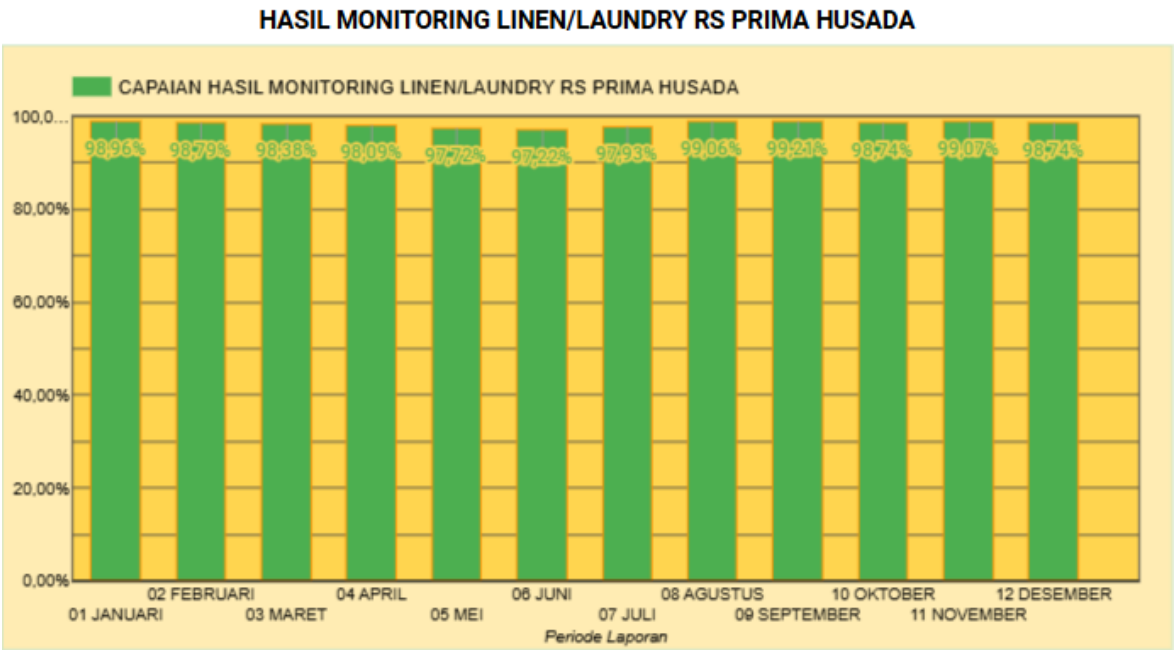
Analisa:	Capaian penanganan dan pengiriman sampah di ruangan berada pada kisaran 91,88% - 99,43%. Ketidakpatuhan terbanyak ada pada pembuangan bungkus spuit dan alcohol swab. Petugas unit sebenarnya paham terkait pemilahan sampah, namun pemilahan tidak dijalankan dengan benar. Faktor penyebabnya diantaranya karena kurangnya pengawasan pada shift tertentu dan peningkatan jumlah beban kerja petugas.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan capaian dan tetap lakukan supervise pemilahan dan pembuangan sampah di unit pelayanan, menegur langsung petugas jika ditemukan kesalahan pembuangan sampah. • Pengoptimalan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. • Menunjuk PIC kebersihan ruangan sebagai pengendali mutu. • Koordinasi dengan coordinator CS terkait perbaikan tempat sampah yang tidak berfungsi baik, dan apabila tidak bisa dibetulkan, didata dan diajukan permintaan yang baru. • Melakukan sosialisasi antar staf tentang pemilahan sampah. • Mengingatkan kembali petugas yang salah membuang sampah untuk meletakkan sampah pada tempat yang sesuai.

8) Penanganan Limbah benda Tajam
Gambar 3.3.1.8 Grafik Pembuangan Sampah Benda Tajam RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Analisa:	Capaian penanganan limbah benda tajam berada pada kisaran 94,92% - 99,81%. Pembuangan benda tajam sudah berangsur membaik, Rumah sakit masih digunakan safety box yang tidak sesuai standar, serta pemilahan sampah belum dilakukan dengan baik oleh petugas unit karena masih ditemukan bungkus spuit yang ikut dimasukkan ke dalam safety box, selain itu juga masih terjadi kasus pajanan karena jarum yang menembus safety box.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan capaian dan monitoring pembuangan benda tajam berkoordinasi dengan unit dan petugas CS. • Melakukan edukasi dan memberikan contoh pada petugas yang berdinasi cara menggantung safety box yang benar. • Meningkatkan monitoring pengawasan kepatuhan pembuangan sampah benda tajam di unit. • Meminta CS untuk segera mengganti safety box dengan yang baru, tidak menunggu sampai full. • Minta petugas untuk selalu menggantungkan safety box pada troli tindakan atau membawa bengkok khusus untuk memilah sampah benda tajam. • Mengedukasi petugas agar lebih berhati-hati jika memegang badan safety box yang berisi benda tajam.

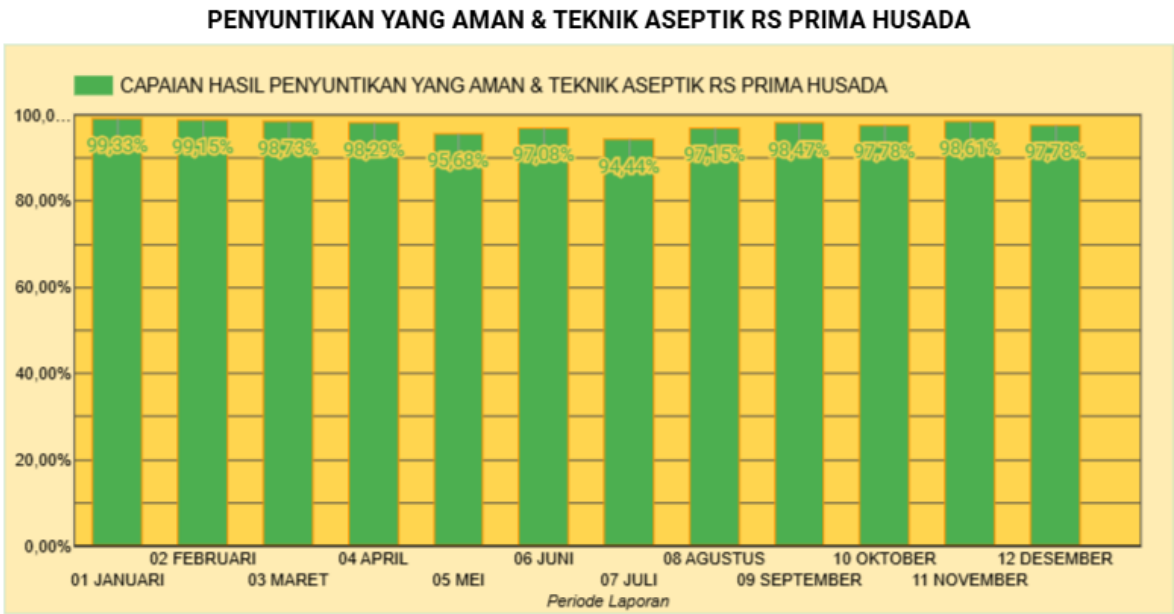
9) Pengelolaan linen/laundry
Gambar 3.3.1.9 Grafik Pengelolaan Linen/Laundry RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Analisa:	• Capaian pengelolaan linen/laundry stabil pada rentang 98-99%, menunjukkan proses kerja berjalan konsisten dan fluktuasi perbulannya menunjukkan system yang masih terkontrol. • Namun walaupun capaian cukup tinggi belum mencapai nilai 100%. Artinya masih ditemukan kejadian/temuan yang tidak sesuai dengan standar dalam pemilahan linen kotor, proses cuci dan pengeringan, distribusi linen bersih dan pencatatan/pelaporan. • Perbaikan perilaku diperlukan untuk mendorong capaian 100% dan memastikan bahwa hasil benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.
----------	--

	• Alur keluar masuk linen kotor dan bersih sudah terpisah. • Kapasitas tong linen kotor di unit kadang sering terlihat penuh sebelum jam pengambilan, sudah dilakukan penambahan tong linen kotor pada unit yang pasiennya banyak. • Pemilahan linen infeksius dan non infeksius sudah dilakukan di unit perawatan, namun masih ditemukan unit yang tidak rapi saat meletakkan linen kotor ke tong linen dan tong linen yang melebihi 2/3 bagian. • Pencatatan serah terima dan kontrol stok linen di lemari linen unit belum terlaksana dengan baik, petugas unit masih tidak tertib melakukan pengorderan linen dan petugas laundry juga tidak mencatat jumlah linen bersih yang disetorkan.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan capaian dan lakukan audit supervisi berkala oleh kepala unit/PJ shift setiap shiftnya untuk menertibkan petugas ruangan yang tidak tertib meletakkan linen kotor. • Melakukan penguatan SPO dan refreshing training untuk pemilahan linen infeksius dan non infeksius, serta pencegahan kontaminasi silang. • Mengedukasi tim laundry untuk rutin membersihkan area laundry dan menata area sesuai dengan tempatnya. • Monitoring pemilahan dan peletakan linen kotor di tong linen kotor unit. • Menerapkan serah terima elektronik untuk dokumentasi serah terima linen. • Menerapkan model pelaporan temuan/kejadian harian seperti linen rusak, hilang, atau adanya alat yang tercampur di linen kotor.

10) Penyuntikan yang aman dan Teknik aseptik
Gambar 3.3.1.10 Grafik Penyuntikan yang Aman RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025

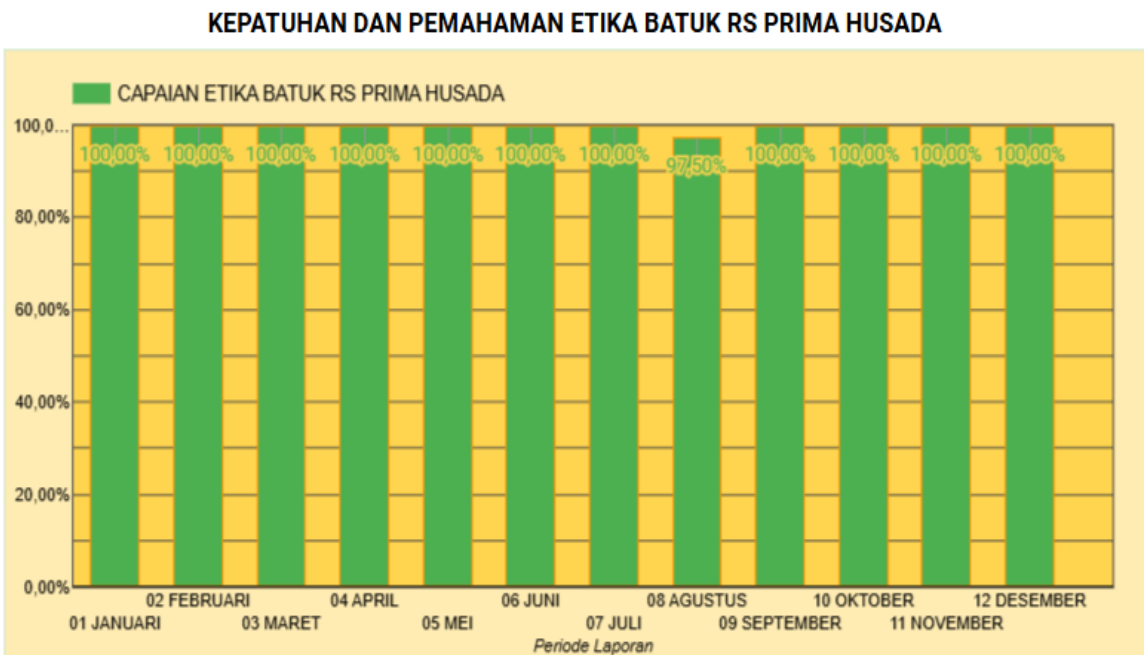


Analisa:	Capaian penanganan dan pengiriman sampah di ruangan berada pada kisaran 94,44% - 99,33%. Penyuntikan yang aman masih perlu ditingkatkan lagi karena kebanyakan dari unit masih sering menyimpan jarum yang sudah tidak steril di troli serta tidak melakukan recapping dengan one hand sehingga risiko tertusuk jarum akan lebih tinggi. Teknik aseptik juga tidak diperhatikan dengan baik dengan
----------	--

	ditemukannya petugas yang menggunakan jarum yang sudah tidak terbungkus atau meletakkan jarum injeksi pada tempat yang beresiko mengkontaminasi jarum tersebut. Selain itu juga obat multidose terkadang masih tidak disimpan dengan baik terutama pada pasien anak-anak.
Tindak Lanjut:	• Meningkatkan monitoring dan supervise terkait proses penyuntikan yang aman. • Koordinasi dengan K3RS terkait pencegahan kejadian pajanan benda tajam (jarum bekas pasien). • Mengajukan kepada petugas unit untuk tidak menyimpan jarum yang sudah tidak terbungkus karena sudah tidak steril meskipun hanya dipakai untuk mengambil cairan NS untuk mengencerkan obat injeksi karena akan merusak sterilitas cairan. • Mengingatkan petugas yang membiarkan obat multidose / cairan yang tidak menyimpan dengan baik. • Mengingatkan petugas pada saat melakukan injeksi untuk membawa bak injeksi agar sterilitas jarum dan obat yang akan diberikan tetap terjaga. • Membiasakan untuk melakukan recapping dengan one hand terutama pada saat mengoplos obat atau dengan membawa safety box saat tindakan sehingga tidak perlu melakukan recapping.

11) Etika Batuk

Gambar 3.3.1.11 Grafik Supervisi Etika Batuk RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025

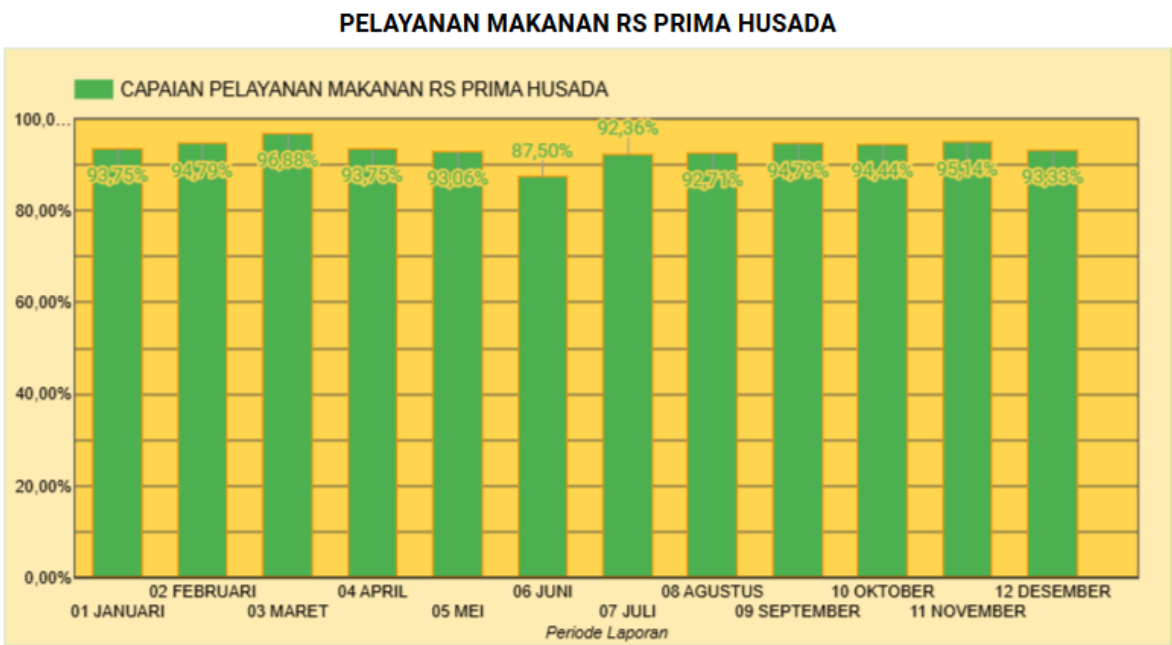


Analisa:	Capaian kepatuhan etika batuk sepanjang tahun didominasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung telah memahami dan menerapkan etika batuk dengan sangat baik. Penurunan Minor pada Bulan Agustus Terjadi sedikit penurunan capaian menjadi 97,5% pada bulan Agustus. Penurunan ini bersifat tidak signifikan, namun tetap perlu dicermati sebagai bentuk kewaspadaan mutu. Kemungkinan Penyebab Penurunan Meningkatnya jumlah pengunjung/pasien (misalnya musim penyakit pernapasan).
----------	--

	Kurangnya pengawasan pada jam sibuk. Kepatuhan pengunjung non-rutin yang belum sepenuhnya memahami etika batuk. Tren Umum Tren keseluruhan sangat stabil dan konsisten. Program edukasi dan pengawasan yang berjalan selama ini efektif.
Tindak Lanjut:	1. Penguatan Edukasi Etika Batuk • Edukasi ulang kepada pasien dan pengunjung melalui: Poster, video edukasi di ruang tunggu, edukasi langsung oleh petugas 2. Peningkatan Pengawasan di Area Padat • Fokus pada ruang tunggu, IGD, dan poliklinik. • Petugas aktif mengingatkan pengunjung yang batuk tidak sesuai etika. 3. Ketersediaan Sarana Pendukung • Memastikan ketersediaan: Masker, tisu, hand sanitizer 4. Evaluasi Berkala • Audit kepatuhan etika batuk setiap bulan. • Analisis khusus jika terjadi penurunan capaian.

12) Pelayanan makanan

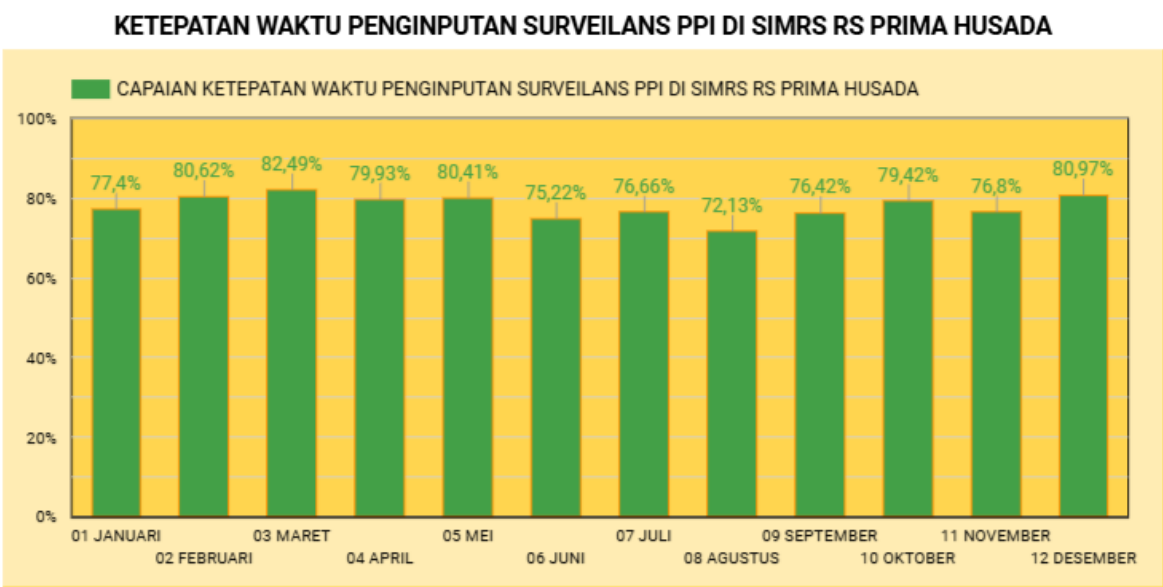
Gambar 3.3.1.12 Grafik Pelayanan Makanan RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Analisa:	• Capaian pelayanan makanan berkisar antara 87,50% - 96,88%. • Penataan alur ruang dapur sudah dilakukan. • APD sudah tersedia namun belum semua petugas tertib memakai APD nya, terutama handgloves. Petugas pemorsian sudah lebih tertib memakai APD. • Sudah dilakukan pembersihan rutin pada gestrack pembuangan dan edukasi pada petugas pencuci untuk melakukan penakaran sabun sesuai kebutuhan, adanya mesin dishwasher sangat membantu mengontrol kebersihan alat makan dengan suhu air panas yang sesuai. • Suhu Gudang penyimpanan masih cukup tinggi meskipun sudah dilakukan penambahan ekshouse fan dan kipas angin untuk mengurangi suhu tinggi karena letaknya memang dekat dengan kompor.
----------	--

	• Jadwal pembersihan troli makanan sudah dibuat dan dilakukan pembersihan setiap selesai mengantarkan makanan. • Ahli gizi sudah rutin melakukan kontrol sampel makanan, dan saat ini sampel makanan langsung disiapkan oleh ahli gizi yang bertugas QC. • Tirai PVC dan pintu penerimaan masih sering dibuka lebar sehingga berisiko lalat masuk meskipun sudah ada lampu serangga.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan capaian dan monitoring pelayanan makanan. • Koordinasi dengan Karu/ahli gizi lainnya untuk terus mengingatkan pentingnya memakai APD lengkap saat pengolahan & pemorsian makanan. • Memberikan pujian pada petugas yang patuh dalam pemakaian APD. • Selalu ingatkan petugas untuk menjaga kebersihan di dapur. • Meningkatkan monitoring kepatuhan petugas penjamah makanan di dapur. • Menginfokan kepada petugas gizi untuk melaporkan thermohygro yang mati pada IPSRS.

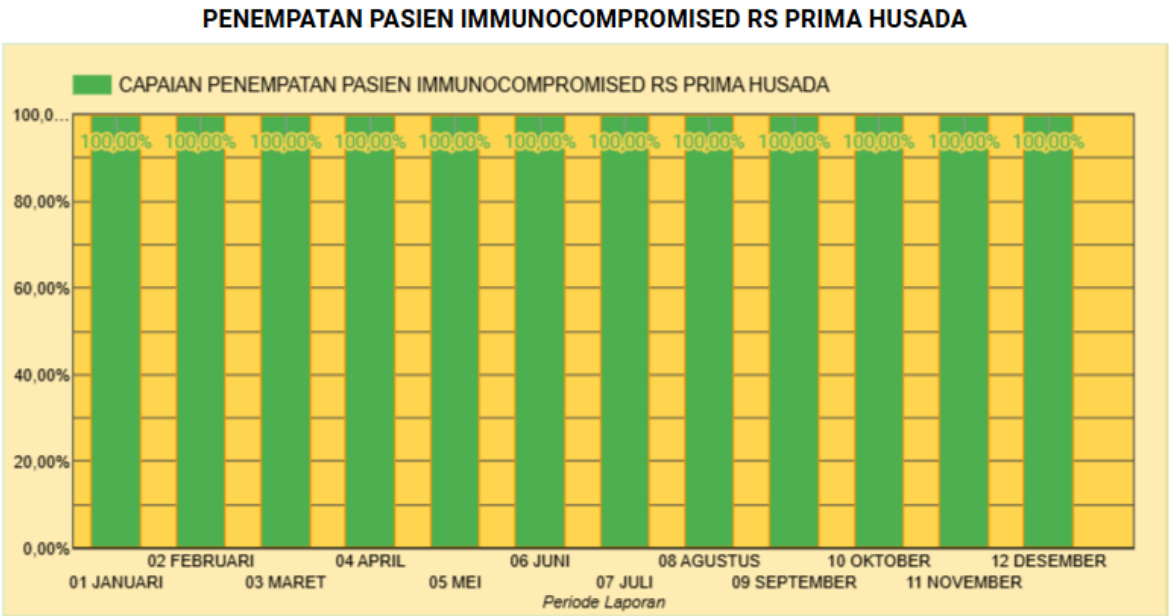
13) Kelengkapan Inputan Surveilans PPI Di SIMRS
 Gambar 3.3.1.13 Grafik capaian kelengkapan inputan surveilans PPI di SIMRS RS Prima Husada



Analisa:	• Rata-rata capaian berada di kisaran 72,13% – 82,49%, belum mencapai target 100% mulai Januari – Desember 2025. • Hal ini menunjukkan konsistensi penginputan belum optimal. • Capaian tertinggi terjadi pada Maret (82,49%) dan Desember (80,97%). Capaian terendah terjadi pada Agustus (72,13%). • Awal tahun (Jan–Mei) relatif stabil dan cenderung mendekati/di atas 80%. • Pertengahan tahun (Juni–Agustus) terjadi penurunan signifikan, dengan puncak penurunan di Agustus. • Akhir tahun (September–Desember) menunjukkan perbaikan bertahap, meskipun masih fluktuatif. Kemungkinan Penyebab: • Beban kerja meningkat (cuti bersama, libur panjang, atau peningkatan pasien). • Kepatuhan petugas terhadap jadwal input belum merata.
----------	---

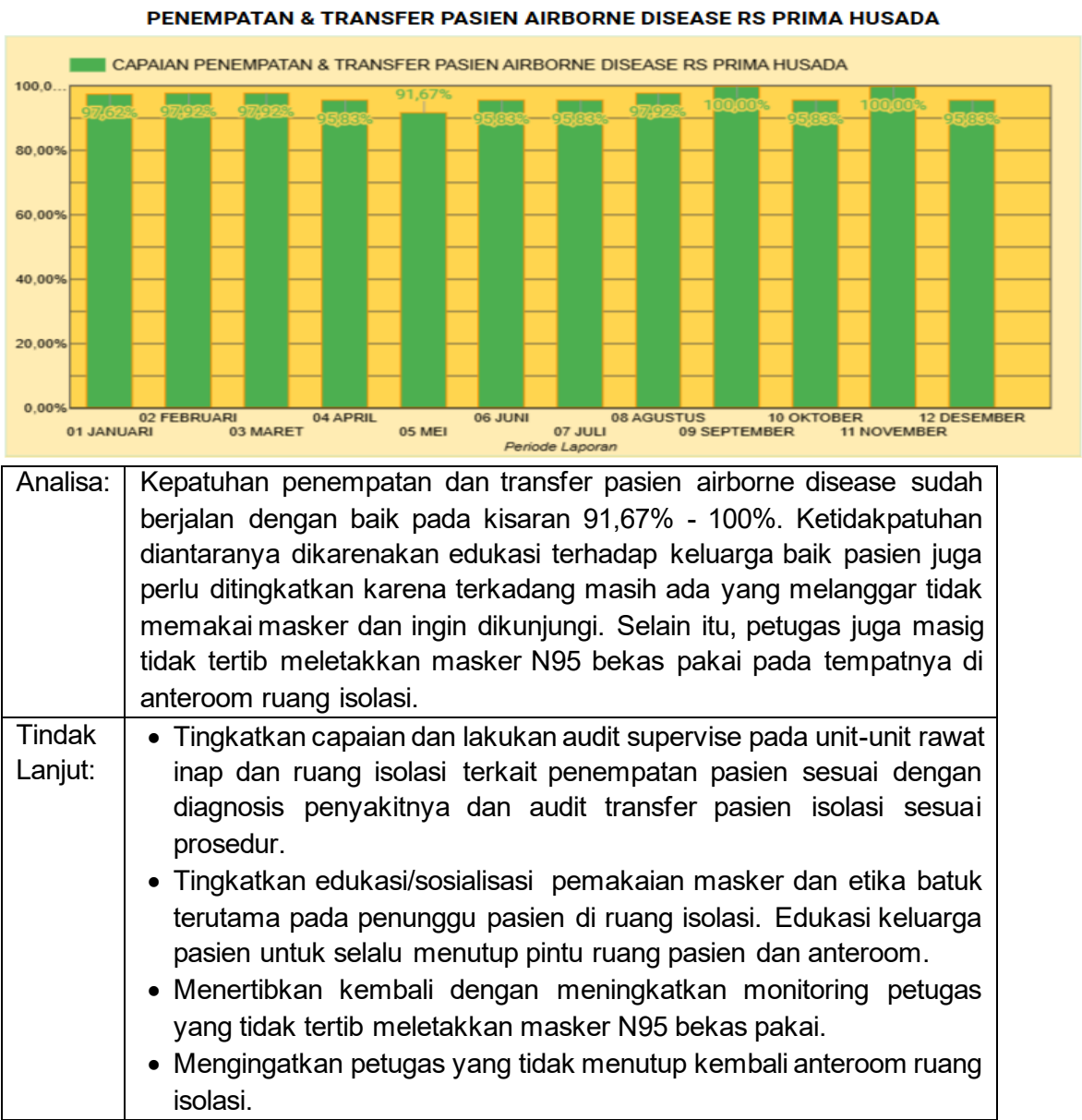
	• Kurangnya monitoring rutin dan pengingat penginputan. • Kendala teknis SIMRS. • Kepatuhan unit: unit yang paling patuh penginputan adalah dari unit Gizi, Maternitas, IRNA 2C. Unit yang paling tidak patuh dari unit Farmasi.
Tindak Lanjut:	Meningkatkan dan menjaga ketepatan waktu penginputan surveilans PPI $\geq 80\%$ secara konsisten setiap bulan. • Refresh sosialisasi alur dan batas waktu penginputan surveilans PPI. • Penunjukan PIC PPI di setiap unit dengan tanggung jawab jelas. • Monitoring capaian ketepatan waktu setiap bulan oleh Tim PPI. • Feedback hasil capaian per unit secara rutin (dashboard/rekap bulanan). • Pembuatan reminder otomatis (WhatsApp/Email/SIMRS) sebelum batas waktu input. • Checklist harian/mingguan penginputan surveilans. • Evaluasi kendala teknis SIMRS terkait input surveilans. • Penyederhanaan form input bila memungkinkan. • Pemberian apresiasi kepada unit dengan capaian terbaik. • Teguran dan pembinaan bagi unit yang berulang kali terlambat. • Evaluasi efektivitas RTL setiap 3 bulan. • Penyesuaian strategi bila target belum tercapai.

- 3.3.2 Kewaspadaan Transmisi
- 1) Kepatuhan penempatan pasien immunocompromise
- Gambar 3.3.2.1 Grafik Kepatuhan Penempatan Pasien Immunocompromise RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025

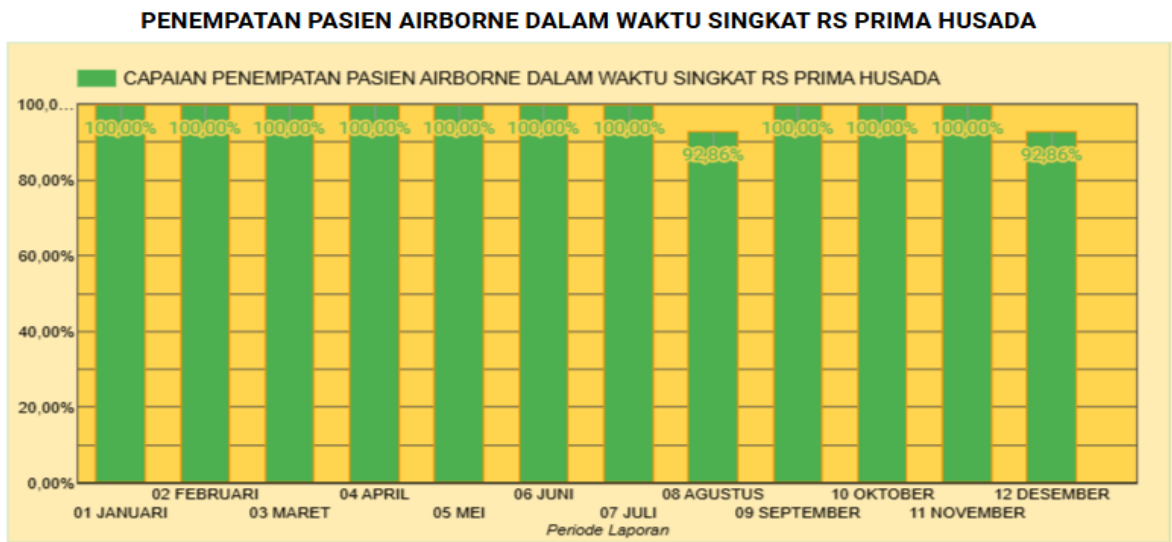


Analisa:	Kepatuhan penempatan pasien immunocompromise sudah berjalan dengan baik, jumlah pasiennya pun tidak terlalu banyak jadi ruangan bisa difungsikan untuk pasien biasa lainnya.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan capaian dan lakukan audit supervisi pada unit-unit terutama IRNA terkait penempatan pasien sesuai dengan diagnosis penyakitnya. • Monitoring pembersihan ruangan dan penempatan pasiennya.

- 2) Kepatuhan penempatan dan transfer pasien airborne disease.
- Gambar 3.3.2.2 Grafik Kepatuhan Penempatan dan Transfer Pasien Airborne Disease RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



- 3) Kepatuhan penempatan pasien infeksi airborne disease dalam waktu singkat
- Gambar 3.3.2.3 Grafik Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksi Airborne Disease dalam Waktu Singkat RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025

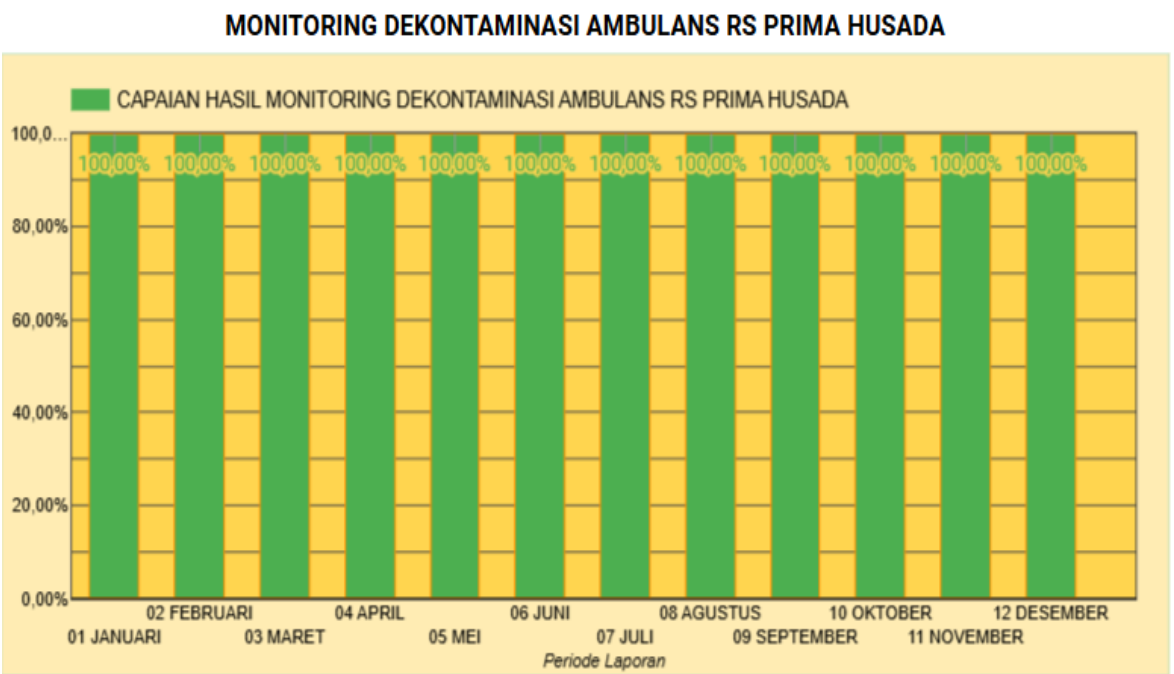


Analisa:	Capaian kepatuhan penempatan pasien airborne dalam waktu singkat berkisar antara 92,86% - 100%. Penurunan pada pertengahan dan akhir tahun ini mengindikasikan adanya beberapa kasus pasien airborne yang tidak langsung dipindahkan ke ruang isolasi. Penyebabnya bisa dikarenakan kondisi ruangan yang penuh, keterlambatan identifikasi pasien (menunggu hasil lab/thorax), dan koordinasi antar unit yang mungkin belum optimal pada jam sibuk.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan capaian dan lakukan audit pada unit-unit terutama IGD dan ruang pasien terkait penempatan pasien sesuai dengan diagnosis penyakitnya. • Melakukan optimalisasi ketersediaan ruang isolasi dengan melakukan kohorting. • Penguatan pada skrining awal pasien airborne disease di IGD.

4) Monitoring kamar jenazah
 Gambar 3.3.2.4 Grafik Monitoring Kamar Jenazah RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025

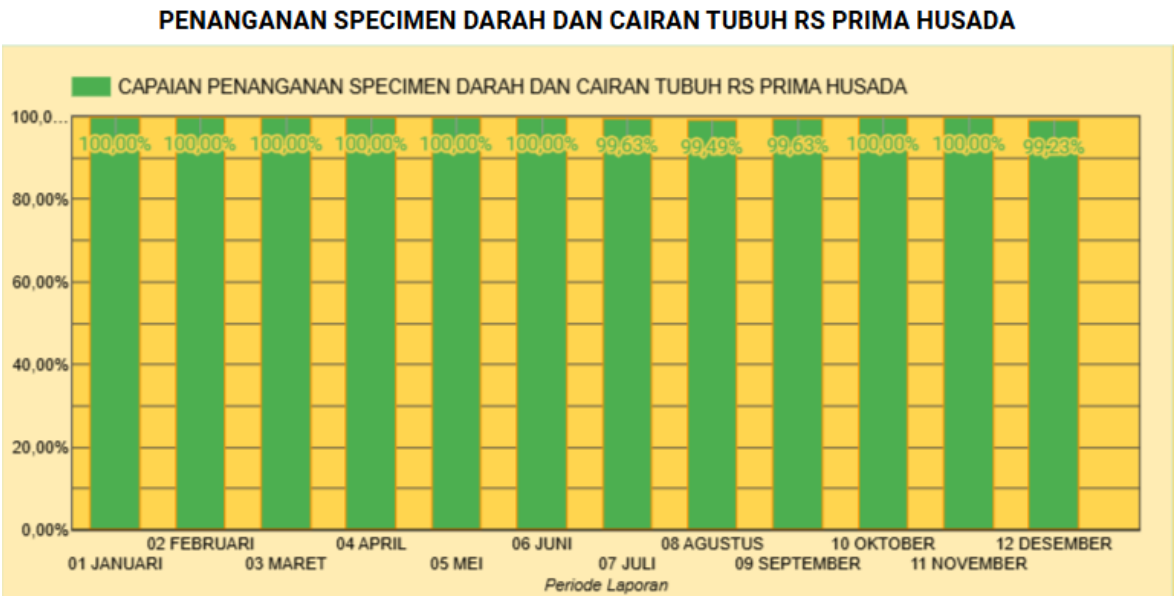


- 5) Dekontaminasi Mobil Ambulans
Gambar 3.3.2.5 Grafik Dekontaminasi Mobil Ambulans RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Analisa:	Dekontaminasi mobil ambulans sudah dilakukan secara rutin. Namun untuk tempat pencucian khusus untuk ambulans belum tersedia.
Tindak Lanjut:	• Pertahankan capaian dan lanjutkan melakukan audit dekontaminasi mobil ambulans, monitoring catatan perawatan mobil ambulans. • Koordinasi dengan tim umum untuk area pembersihan/pencucian mobil ambulans.

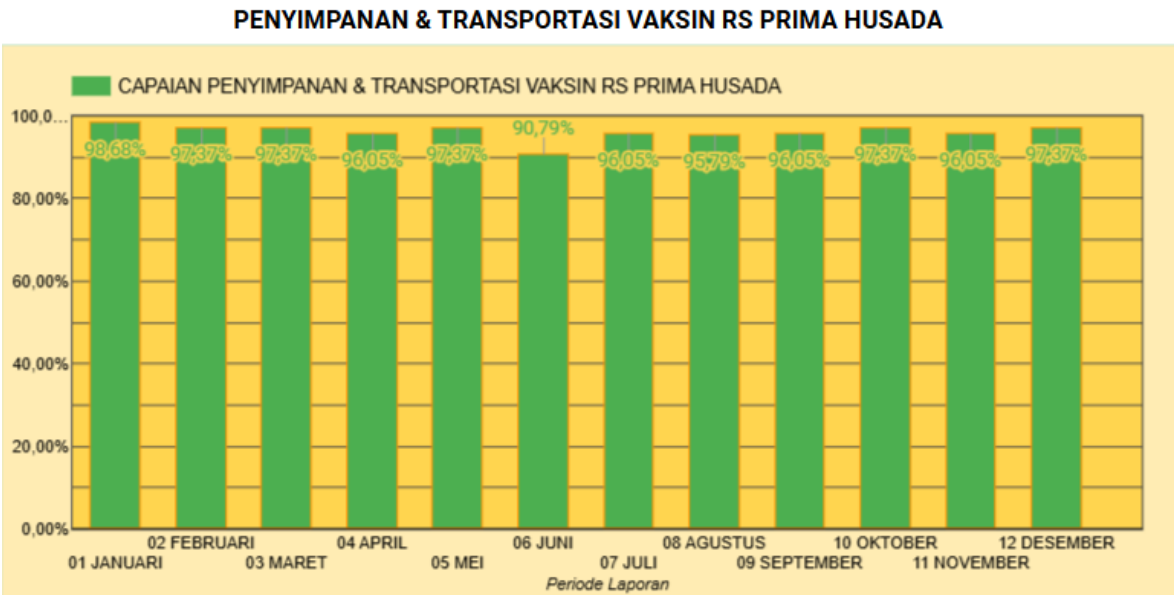
- 6) Penanganan specimen darah dan cairan tubuh
Gambar 3.3.2.6 Grafik Penanganan Specimen Darah dan Cairan Tubuh RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Analisa:	Capaian penanganan specimen darah dan cairan tubuh rata-rata sudah cukup baik. Hanya saja masih ditemukan petugas yang kurang menjaga kebersihan ruangan tempat pengambilan sampling, setelah selesai Tindakan. Pada unit perawatan juga tidak tertib menjaga
----------	---

	kebersihan troli tindakannya sehingga seringkali noda darah tercecer di tempat tabung sampel darah.
Tindak Lanjut:	• Pertahankan pelayanan dan tingkatkan supervise terkait penanganan specimen pemeriksaan. • Mengingatkan petugas untuk segera membuang hasil yang sudah didokumentasikan. • Minta petugas untuk memotong/membuang bagian tempat tabung sampel yang terkena darah atau membersihkan trolinya.

- 7) Penyimpanan dan transportasi vaksin
- Gambar 3.3.2.7 Grafik Penyimpanan dan Transportasi Vaksin RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Analisa:	Penyimpanan dan transportasi vaksin sudah dilakukan dengan baik, dengan capaian berkisar 90,79% - 98,68%, namun perlu diperhatikan karena pengukuran suhu lemari pendingin yang tidak dilakukan secara rutin oleh petugas, serta kebersihannya perlu ditingkatkan.
Tindak Lanjut:	• Tingkatkan capaian dan lanjutkan melakukan audit penyimpanan dan transportasi vaksin. • Koordinasi dengan Ka Instalasi Farmasi untuk menunjuk dan menjalankan tugas PJ shift dengan benar supaya tidak memberatkan kepada Ka Instalasi saja.

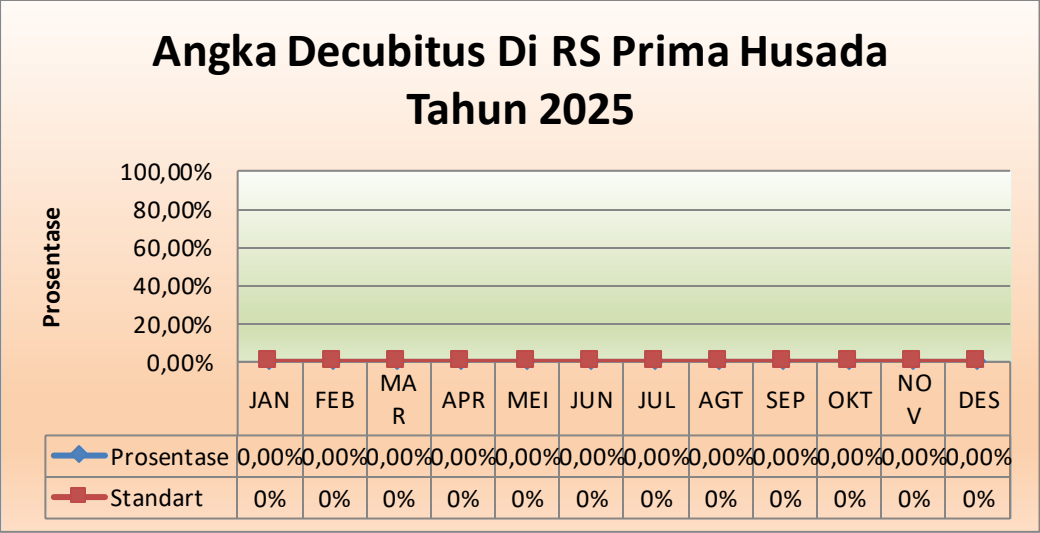
3.3.3 Evaluasi Program Surveilans dan Peningkatan Mutu Pelayanan

1) Program Surveilans HAI's

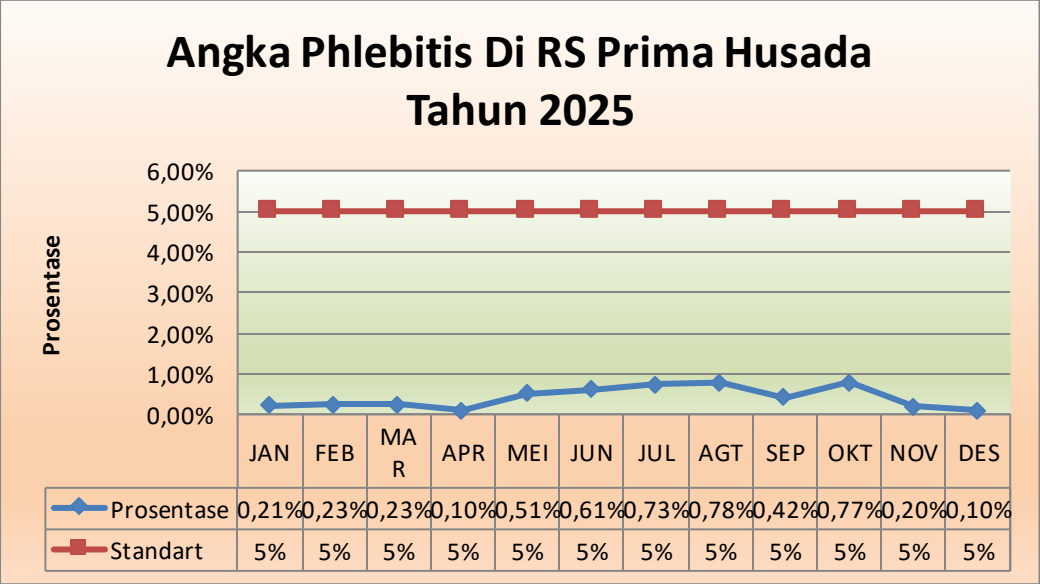
Tabel 3.3.3.1 Monitoring Hasil Surveilans HAI's PPI dan Mutu PPI bulan Januari – Desember 2025:

Jenis HAI's & Mutu PPI	Standart Nasional	Rate Infeksi % atau ‰ (Tahun 2025)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%	0,53%	0,27%	0,23%	0,49%	0,51%	0,25%	0%	0%
IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%	0,51%	0,61%	0,73%	0,78%	0,42%	0,77%	0,2%	0,1%
Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%	85,58%	85,32%	85,57%	85,61%
Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,39%	93,56%	93,73%	93,79%	94,3%	94,33%	95,1%	96,88%	96,86%
Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%	93,42%	93,45%	93,74%	93,77%	94,35%	94,35%	95,24%	97,28%	97,32%
Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

Gambar 3.3.3.1.e Grafik Angka Decubitus RS Prima Husada Tahun 2025



Gambar 3.3.3.1.f Grafik Angka Phlebitis RS Prima Husada Tahun 2025



❖ Analisa: Angka HAIs di Rumah Sakit Prima Husada masih memenuhi standar yang ada. Selama tahun 2025, angka IDO jauh di bawah standar yang ditetapkan. Terlihat fluktuasi ringan pada beberapa bulan (April, September), namun tidak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Angka IDO bulanan berada pada kisaran $\pm 0,27\%$ – $0,53\%$. Pada monitoring VAP, tidak ditemukan kasus VAP selama tahun 2025. Hal ini menunjukkan kepatuhan yang sangat baik terhadap bundle VAP (kebersihan tangan, posisi head-up, oral hygiene, evaluasi ekstubasi). Sama halnya dengan ISK, IADP dan decubitus, pada tahun ini juga memenuhi standar 0%. Sedangkan angka phlebitis masih jauh di bawah standar, meskipun terdapat sedikit peningkatan pada pertengahan tahun (Mei–Agustus). Namun, nilai tersebut tetap dalam batas aman, rata-rata berkisar antara 0,21%–0,78%. Pelaksanaan pemasangan dan perawatan infus sudah cukup baik, namun tetap perlu kewaspadaan.

❖ Evaluasi:

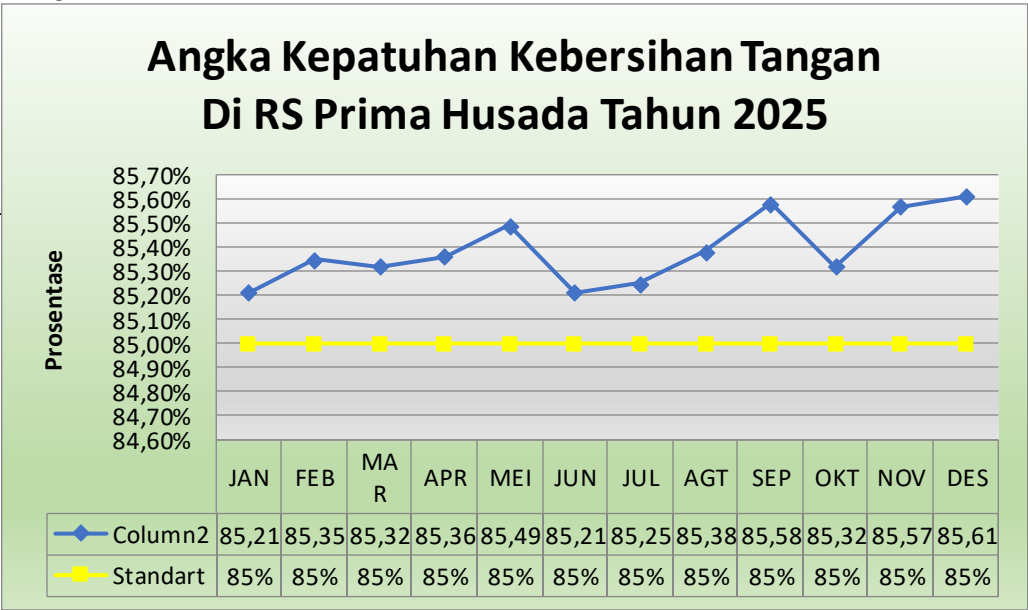
1. Capaian
 - Seluruh indikator HAI's memenuhi bahkan melampaui standar nasional.
 - Tidak ditemukan kejadian VAP, IADP, ISK, dan decubitus.
 - Angka IDO dan phlebitis tetap rendah dan terkendali.
2. Faktor Pendukung
 - Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan (hand hygiene).
 - Penerapan bundle PPI secara konsisten.
 - Monitoring dan surveilans PPI yang dilakukan secara rutin.
 - Edukasi dan sosialisasi PPI kepada tenaga kesehatan berjalan baik.
3. Area yang Perlu Diperhatikan
 - Fluktuasi ringan pada angka IDO dan phlebitis menunjukkan perlunya: Penguatan supervisi di unit rawat inap dan kamar operasi dan evaluasi teknik pemasangan infus dan perawatan luka operasi.

- ❖ Rekomendasi Tindak Lanjut Tahun Berikutnya:
 1. Mempertahankan capaian nol kasus untuk VAP, IADP, ISK, dan decubitus.
 2. Meningkatkan audit kepatuhan bundle PPI, khususnya pada tindakan invasif.
 3. Refresh training PPI secara berkala bagi tenaga kesehatan.
 4. Analisa kasus individual jika terjadi peningkatan angka IDO atau phlebitis.
 5. Penguatan budaya keselamatan pasien melalui umpan balik hasil surveilans ke unit kerja.

2) Evaluasi Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan PPI.

- 1. Upaya menurunkan risiko infeksi pada petugas kesehatan.
 - a) Monitoring Kebersihan Tangan bulan Januari – Desember 2025:

Gambar 3.3.3.2.1.a Grafik Monitoring Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan bulan Januari – Desember 2025

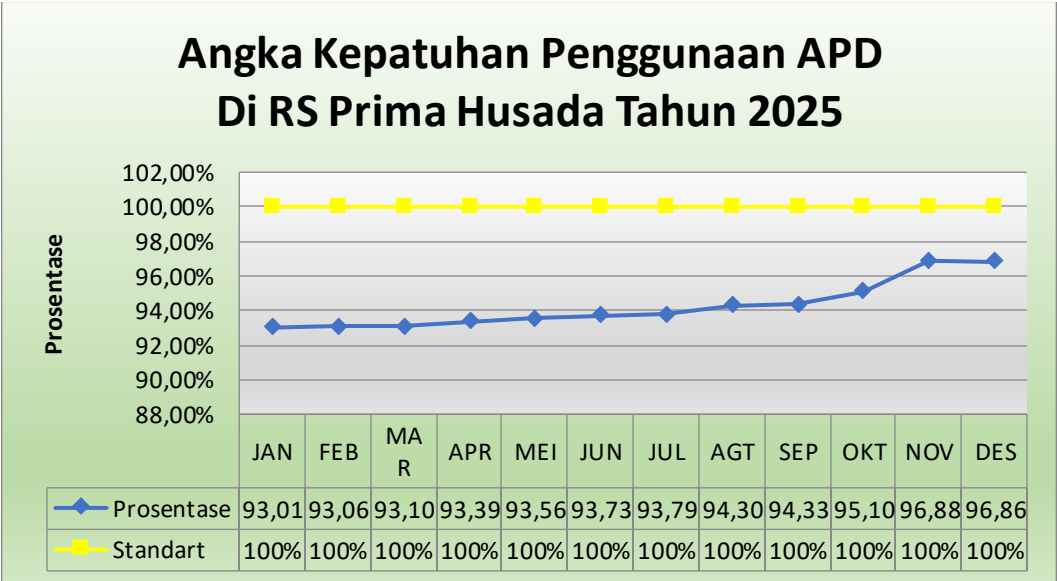


Analisa: Berdasarkan grafik Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan RS Prima Husada Tahun 2025, terlihat bahwa kepatuhan hand hygiene selama satu tahun berada pada kisaran $\pm 85,21\%$ – $85,61\%$. Secara umum, capaian ini menunjukkan kinerja yang cukup stabil.

Tren data menunjukkan adanya fluktuasi ringan antar bulan. Peningkatan kepatuhan terlihat pada bulan Mei, September, November, dan Desember, dengan capaian tertinggi pada bulan Desember ($\pm 85,61\%$). Sebaliknya, penurunan relatif terjadi pada bulan Juni dan Oktober, yang mengindikasikan kemungkinan pengaruh beban kerja, kepadatan pasien, atau penurunan kewaspadaan petugas terhadap kepatuhan kebersihan tangan.

Meskipun sebagian besar capaian berada di sekitar standar, kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan kebersihan tangan belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh unit. Hal ini menandakan perlunya penguatan edukasi, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan agar kepatuhan dapat meningkat dan dipertahankan secara optimal.

b) Monitoring Kepatuhan penggunaan APD bulan Januari – Desember 2025:
Gambar 3.3.3.2.1.b Grafik Kepatuhan penggunaan APD RS Prima Husada
bulan Januari – Desember 2025



Analisa: Berdasarkan grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD RS Prima Husada Tahun 2025, terlihat bahwa kepatuhan penggunaan APD selama satu tahun berada pada kisaran 93,01%–96,86%. Secara umum, capaian ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun, meskipun belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu 100%.

Pada awal tahun (Januari–Maret), angka kepatuhan berada pada kisaran 93,01%–93,10%, kemudian mengalami peningkatan bertahap mulai bulan April hingga Agustus. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada bulan Oktober hingga Desember, dengan capaian tertinggi pada bulan November dan Desember (96,86%). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD seiring dengan penguatan pembinaan dan monitoring.

Meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat selisih sekitar 3% dari standar 100%, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan penggunaan APD belum sepenuhnya konsisten di seluruh unit dan seluruh waktu. Faktor yang kemungkinan berpengaruh antara lain beban kerja, kepatuhan individu, serta kebiasaan penggunaan APD pada kondisi tertentu.

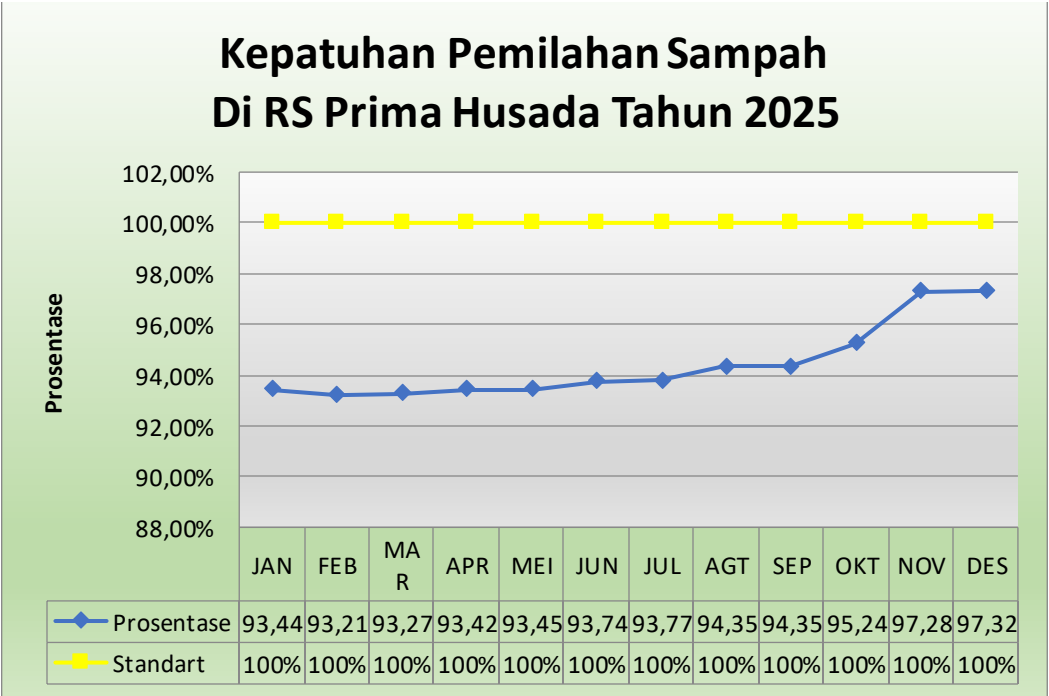
Rencana Tindak Lanjut:

Tujuan	Sasaran	Strategi / Tindakan	Pelaksana	Waktu
Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	Seluruh tenaga kesehatan	Edukasi ulang penggunaan APD sesuai risiko melalui PPI Quick Tips	Tim PPI / IPCN	Triwulan I 2026
Menutup gap capaian menuju 100%	Unit dengan kepatuhan rendah	Monitoring langsung dan umpan balik hasil observasi	IPCN / Link Nurse	Rutin bulanan
Memperkuat budaya keselamatan kerja	Tenaga kesehatan di unit pelayanan	Penguatan disiplin APD melalui briefing awal shift	Kepala Ruangan	Berkelanjutan
Menjamin ketersediaan APD	Seluruh unit pelayanan	Monitoring stok, distribusi, dan jenis APD sesuai risiko	Logistik, Tim PPI	Rutin
Evaluasi berkelanjutan	Manajemen & unit terkait	Evaluasi capaian indikator penggunaan	Tim PPI / PMKP	Setiap triwulan

Tujuan	Sasaran	Strategi / Tindakan	Pelaksana	Waktu
		APD dan pelaporan ke PMKP		

- c) Pemeriksaan kesehatan petugas secara berkala.
- Evaluasi:
- Pemeriksaan kesehatan karyawan untuk tahun ini sudah dilakukan mulai tanggal 22 – 28 September 2025, dimana pemeriksaan yang dilakukan meliputi anamnesa & pemeriksaan vital sign, skrining DM (cek GDP), dan pemeriksaan HbsAg untuk all staf dan pemeriksaan tambahan thorax dan cek HIV untuk unit tertentu. Dengan evaluasi kehadiran yang lebih meningkat dari tahun lalu dimana didapatkan 12 orang tidak melakukan MCU rutin tahunan ini, dan bagi yang tidak mengikuti sudah diberikan peringatan oleh SDM dan diwajibkan untuk memberikan hasil tes kesehatan secara mandiri.
 - Belum dilakukan pemeriksaan khusus untuk pendengaran pada petugas laundry, hanya pemeriksaan fisik saja area pendengaran petugas pada saat MCU dan hasilnya masih baik.
 - Sudah dilakukan pemeriksaan rectal swab khusus pada petugas penjamah makanan rutin pada bulan Juli 2025, dengan hasil ada 2 penjamah makanan yang memiliki hasil kuman pathogen (Salmonela thypi). Hygiene penjamah makanan sangat penting diperhatikan karena dapat menjadi sumber pembawa penyakit pada pasien. Kedua penjamah makanan tersebut sudah dikonsultasikan pada dokter untuk memperoleh pengobatan.
- d) Monitoring Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan

Gambar 3.3.3.2.1.d Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



Analisa: Berdasarkan grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah RS Prima Husada Tahun 2025, terlihat bahwa kepatuhan pemilahan sampah selama satu tahun berada pada kisaran 93,21%–97,32%. Secara umum, capaian ini menunjukkan tren peningkatan yang positif sepanjang tahun, meskipun belum mencapai standar yang ditetapkan yaitu 100%. Pada periode Januari hingga Mei, tingkat kepatuhan relatif stabil di kisaran 93,21%–93,45%, yang mengindikasikan bahwa pemahaman petugas terhadap

pemilahan sampah sudah baik namun belum konsisten sepenuhnya. Mulai Juni hingga Agustus, terlihat peningkatan bertahap hingga mencapai 94,35%–93,77%, dan peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada bulan Oktober hingga Desember, dengan capaian tertinggi pada bulan Desember (97,32%).

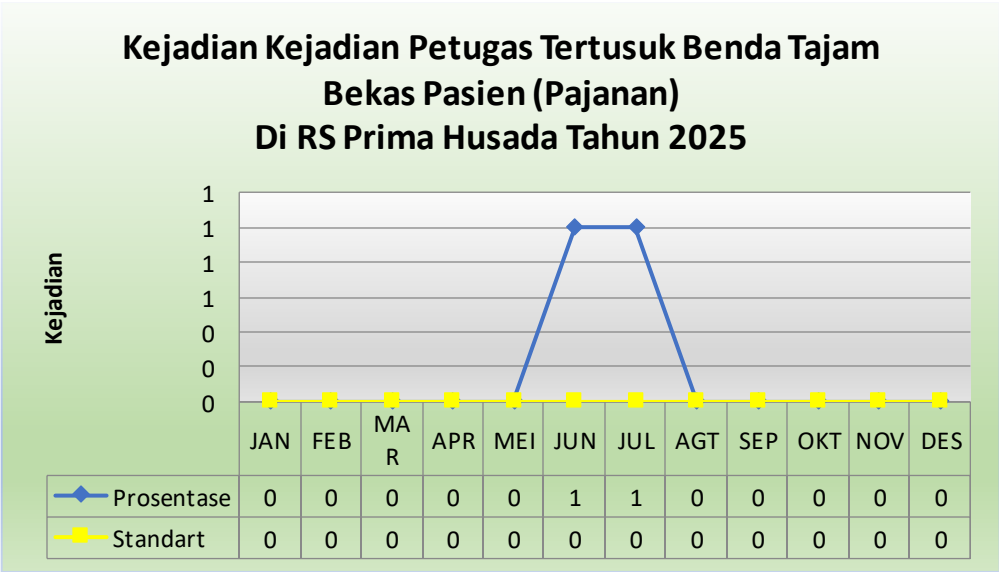
Peningkatan pada akhir tahun menunjukkan bahwa edukasi PPI, pembinaan petugas, serta monitoring pemilahan sampah mulai berjalan lebih efektif. Namun demikian, masih terdapat selisih capaian terhadap standar 100%, yang mengindikasikan perlunya penguatan budaya kepatuhan, pengawasan rutin, dan penegasan kembali SOP pemilahan sampah di seluruh unit pelayanan.

Rencana tindak lanjut:

Tujuan	Sasaran	Strategi / Tindakan	Pelaksana	Waktu
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah sesuai standar	Seluruh tenaga kesehatan dan petugas kebersihan	Edukasi ulang pemilahan sampah sesuai kode warna melalui PPI Quick Tips	Tim PPI / IPCN	Triwulan I 2026
Menutup gap capaian menuju 100%	Unit dengan kepatuhan rendah	Monitoring langsung dan umpan balik hasil observasi	IPCN / Sanitarian	Rutin bulanan
Memperkuat budaya disiplin pengelolaan limbah	Tenaga kesehatan & CS	Penguatan disiplin melalui briefing dan reminder visual di area kerja	Kepala Ruangan / IPSRS	Berkelanjutan
Menjamin sarana pemilahan sampah	Seluruh unit pelayanan	Monitoring ketersediaan tempat sampah sesuai warna dan label	IPSRS / Tim PPI	Rutin
Evaluasi berkelanjutan	Manajemen & unit terkait	Evaluasi indikator kepatuhan pemilahan sampah dan pelaporan ke PMKP	Tim PPI / PMKP	Setiap triwulan

e) Penanganan pasca pajanan dari pasien (Terkena benda tajam bekas pasien)

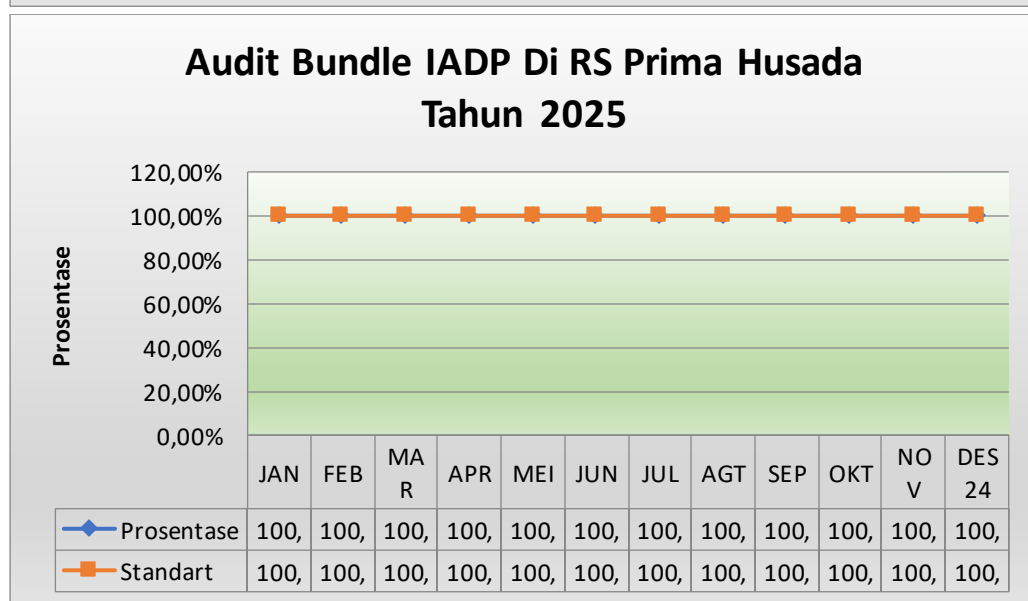
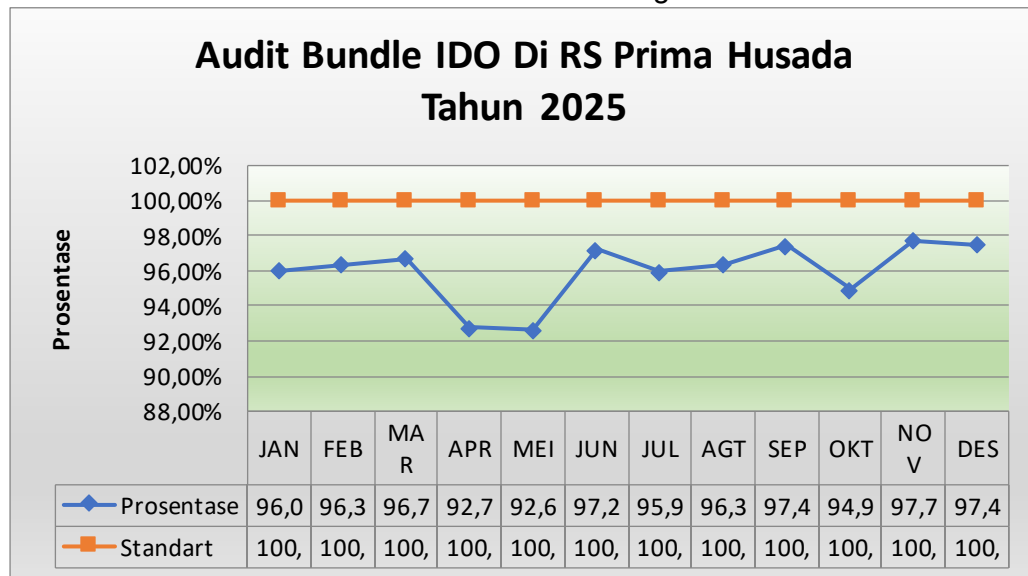
Gambar 3.3.3.2.1.e Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien RS Prima Husada bulan Januari – Desember 2025



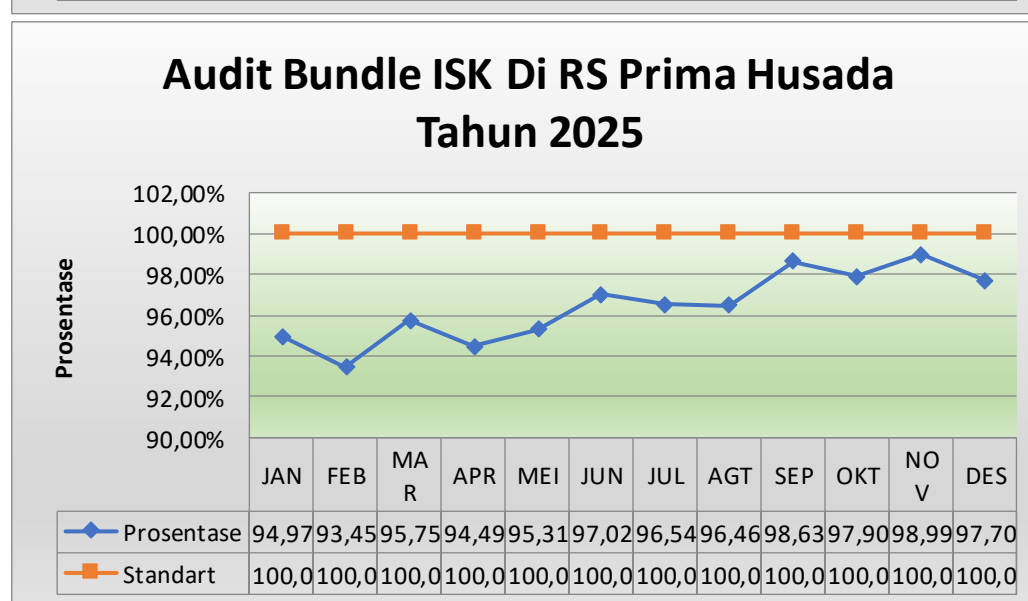
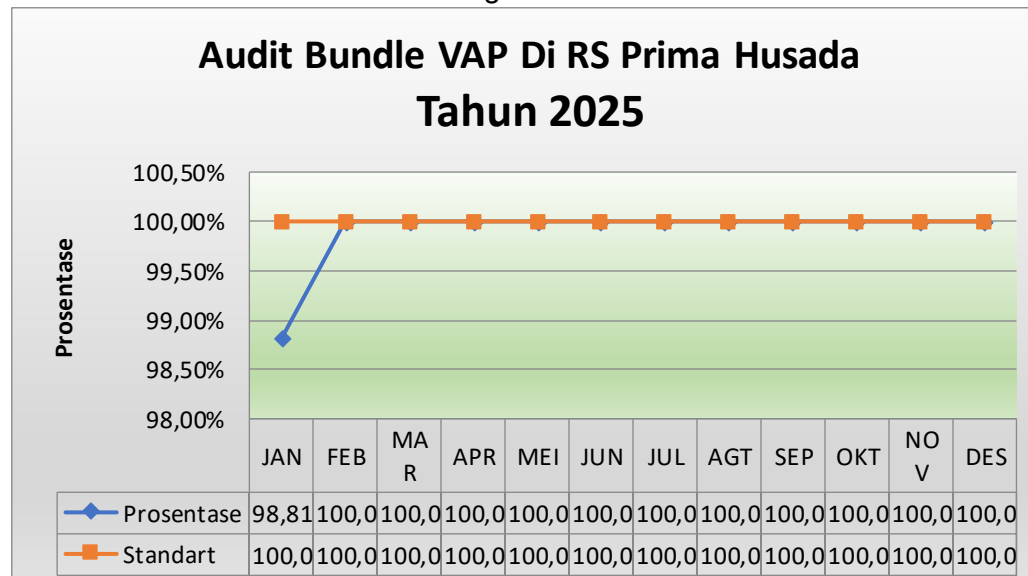
-
- 1 diantaranya dikarenakan kondisi alkes/jarum yang bengkok saat dilakukan penutupan tutup jarum. 1 orang lainnya mengalami pajanan tusukan jarum karena safety box yang tembus jarum, karena pada saat petugas memegang badan safety box, petugas tersebut terkena jarum yang menebus lapisan safety boxnya. Dari hasil tracing pasien, tidak ditemukan penyakit menular pada pasien dan pada saat MCU sudah dilakukan cek HbsAg maupun HIV dan hasilnya baik.
2. Upaya menurunkan risiko infeksi pada pelayanan pasien.
- a) Pemantauan kualitas udara.
Evaluasi: dilakukan pemantauan udara pada bulan Juni 2025 di ruang IKO 3, IGD, Isolasi 5C, CSSD dan LAF dengan hasil memenuhi syarat.
 - b) Pemantauan kualitas air.
Evaluasi: Pemeriksaan mikrobiologi air bersih dilakukan pada 2 sumber air dengan sampling air di ruang IKO (sumber sumur bor) dan air kran di Gedung DPM dengan hasil memenuhi syarat. Pemeriksaan juga dilakukan pada sumber air minum yang digunakan di RS Prima Husada dengan hasil memenuhi syarat.
 - c) Pemantauan kebersihan lantai & dinding.
Evaluasi: Sudah dilakukan pemeriksaan swab lantai dan dinding secara rutin pada bulan Juni 2025 pada unit seperti: CSSD, IGD, IKO, IRJA bedah, IRNA 4A, Isolasi 5C, LAF, NICU, Tindakan Maternitas, Dapur (R. Pemorsian) dengan hasil semuanya memenuhi syarat. Desember 2025 sudah dilakukan permohonan kembali pemeriksaan lingkungan namun belum mendapatkan jadwal dari Labkesda ka. Malang.
 - d) Pemantauan sterilitas alat medis, linen, dan meja operasi.
Evaluasi: Sudah dilakukan rutin pemeriksaan swab alat medis steril, linen steril, dan meja operasi pada bulan Juni 2025 dan didapatkan hasil memenuhi syarat yang dilakukan oleh Lab Dinkes Kab. Malang kecuali pada alat rawat luka dimana didapatkan angka lempeng total 10 CFU/cm², nilai normal <1. Evaluasi kembali proses penyeterilan mulai dari cleaning sampai penyeterilan. Dicek kembali alat yang dilakukan pemeriksaan apakah ada yang berkarat atau tidak dan dianjurkan tidak digunakan karena terdapat permukaan yg mulai berkarat. Sudah dilakukan cek fungsi alat steril apakah berfungsi baik, termasuk kertas indicator steril, serta waktu penyeterilan yang sudah sesuai.

e) Monitoring Audit Bundle HAIs.

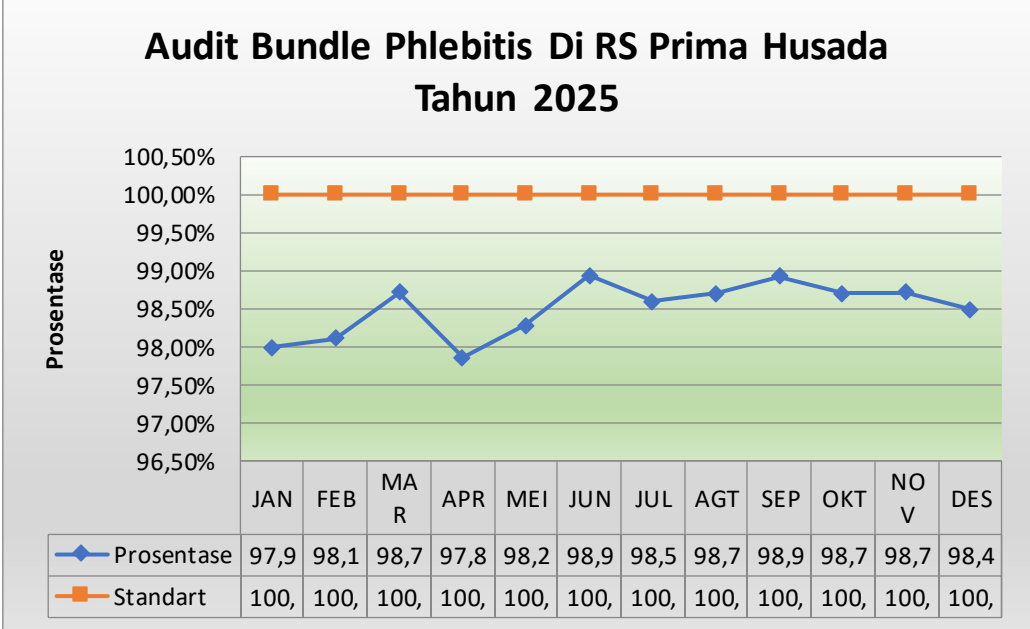
Gambar 3.3.3.2.2.e Grafik Monitoring Audit Bundle HAIs



Gambar 3.3.3.2.2.e Grafik Monitoring Audit Bundle HAIs



Gambar 3.3.3.2.2.e Grafik Monitoring Audit Bundle HAIs



Evaluasi: Kegiatan pencegahan risiko infeksi (Audit Bundle HAIs) sudah dilakukan dengan baik oleh petugas di unit, namun masih ada beberapa unit yang tidak tertib mendokumentasikan pada form audit bundle HAIs dan

Sebagian petugas hanya mengandalkan IPCLN untuk pengisiannya. Dengan disambungkannya data register dengan data audit bundle's HAI's, mempermudah petugas untuk menginputkan data sehingga tidak terlalu bergantung pada IPCLN namun seluruh anggota unit turut aktif.

- f) Melaksanakan pengkajian dampak renovasi / pembongkaran / pembangunan Gedung dengan program ICRA.

Evaluasi: Program ICRA belum berjalan dengan baik pada 2 tahun sebelumnya, belum dapat dilakukan evaluasi pada tahun 2025 dikarenakan belum ada kegiatan renovasi/pembangunan pada tahun 2025 ini, namun terkait dokumentasi kegiatan pada tahun 2024 sudah dilakukan dengan baik.

3.3.4 Evaluasi Program Manajerial

- 1) Menyusun program kerja Komite PPI.
Evaluasi: tersusunnya program kerja Komite PPI tahun 2026 dan dilaporkan kepada direktur dan keuangan.
- 2) Menyusun rencana kebutuhan anggaran.
Evaluasi: tersusunnya program kerja Komite PPI tahun 2026 yang didalamnya juga mencakup rencana anggaran dari Komite PPI, dan dilaporkan dan dikumpulkan di bagian keuangan RS.
- 3) Melakukan pertemuan berkala anggota Komite PPI.
Evaluasi: Rapat Komite PPI rutin dilakukan setiap satu bulan sekali baik melalui online maupun offline, lebih banyak dilakukan online karena anggota banyak yang bertugas shift sehingga lebih efisien & lebih banyak prosentase kehadirannya jika dilakukan online.
- 4) Melakukan pertemuan berkala antar Komite RS.
Evaluasi: Rapat antar Komite RS khususnya dengan Komite PMKP belum terlaksana rutin, sudah terlaksana pada triwulan 3 dan 4 saja saat penanganan PIC data mutu dan surveilans serta saat penentuan indikator mutu, rapat juga dihadiri SDM dan Komite lain seperti K3RS dan PKRS. Lebih ditingkatkan kembali untuk terlaksananya rapat antar komite.
- 5) Melakukan pertemuan berkala dengan direktur dan unit di RS.
Evaluasi: Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Direktur, Kabid, dan seluruh perwakilan kepala ruang tidak lagi rutin dilakukan, pertemuan isidentil sesuai dengan undangan dari direktur. Namun sebagai bentuk evaluasi yang

disampaikan kepada kepala ruang, IPCN mengikuti rapat dengan bidang keperawatan dan komite keperawatan.

- 6) Mengadakan pertemuan isidentil:
Evaluasi: Tidak dilakukan pertemuan isidentil dengan anggota komite PPI lainnya pada tahun ini.

3.3.5 Evaluasi Program Edukasi Pasien, Keluarga Pasien, dan Pengunjung.

Tabel 3.3.5 Kegiatan PKRS Komite PPI tahun 2025

No	Kegiatan PKRS	Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan
1	Kegiatan sosialisasi dan edukasi kelompok pasien dan keluarga	• Kegiatan edukasi kelompok tiap bulan memenuhi rata-rata 8x edukasi, dengan total dalam 1 tahun sebanyak 130x. • Kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang PPI (kebersihan tangan, etika batuk, PHBS) kepada pasien, keluarga dan pengunjung secara berkala oleh anggota Komite PPI dengan koordinasi dengan Tim PKRS. Terdata jumlah pengunjung tahun ini yang di edukasi PPI sebanyak 889 orang pada edukasi kelompok dan paling banyak dilakukan di ruang koridor rawat inap dan ruang tunggu rawat jalan.
2	Edukasi melalui media audiovisual.	• Dilakukan edukasi kelompok dengan penayangan video edukasi cuci tangan di ruang tunggu poli dan farmasi mulai bulan November 2023 dan sampai saat ini masih terus dilakukan dengan jeda waktu pemutaran video sekitar 30 menit sekali. (25 x tayang /hari) Namun pada bulan Oktober 2024 mulai berkurang karena adanya tambahan video edukasi lainnya menjadi 60 menit sekali penayangan atau 12x /hari sampai saat ini.
3	Edukasi pasien di RM	• Edukasi ini masih belum berjalan rutin dengan baik, masih ditemukan petugas yang hanya menuliskan saja di RM dan saat dikonfirmasi ke pasien, hanya diingatkan untuk sering melakukan cuci tangan dengan melihat stiker HH yang ditempel di bed. Unit yang rajin melakukan edukasinya dan memintakan bukti TTD di IRNA maternitas dan neonatologi.
3	Video edukasi pendek “Tik-tok”	• https://sites.google.com/view/komite-ppi-rs-prima-husada/kegiatan-ppi/sosialisasi-ppi/video-kreasi-edukasi-ppi
4	Kegiatan sosialisasi dan edukasi PPI kepada staf	• Dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang PPI (kebersihan tangan, etika batuk pemakaian APD, dan pemilahan sampah) kepada sesama staf oleh anggota Komite PPI pada saat jam dinas, kegiatan edukasi oleh PPI berjalan di unit-unit pelayanan. Dokumentasi kegiatan dikoordinasikan juga dengan tim PKRS. Total pelaporan staf yang diedukasi pada bulan ini sebanyak 432 staf secara berulang.
Bukti dokumentasi sosialisasi:		• Dokumentasi sosialisasi

Evaluasi:

- 1) Edukasi terhadap pasien dilakukan oleh seluruh unit perawatan dengan materi hand hygiene dan etika batuk serta materi yang berhubungan dengan PPI lainnya seperti PHBS, perawatan luka dan penggunaan obat antibiotik pada seluruh pasien dengan didokumentasikan pada lembar edukasi pada rekam medis menggunakan media leaflet dan praktek langsung.
- 2) Edukasi secara kelompok pasien/keluarga/pengunjung terdokumentasi dengan baik mulai bulan Januari 2025 dengan jadwal minimal 8x/bulan dilakukan di ruang tunggu rawat jalan maupun rawat inap dengan capaian edukasi sebanyak 889 orang yang teredukasi dalam edukasi kelompok dengan jumlah edukasi sebanyak 130 kali edukasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) selama tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada, dapat disimpulkan bahwa secara umum program PPI telah berjalan dengan baik, terstruktur, dan sesuai dengan regulasi serta standar nasional yang berlaku. Capaian indikator surveilans HAIs menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh indikator utama seperti VAP, IADP, ISK, dan dekubitus tercapai 0 kasus, sementara angka IDO dan flebitis berada jauh di bawah standar nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas penerapan bundle PPI dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur pencegahan infeksi.

Kepatuhan kewaspadaan standar (kebersihan tangan, penggunaan APD, pemilahan limbah, pengelolaan linen, sterilisasi, dan pengendalian lingkungan) secara umum berada pada kategori baik hingga sangat baik, meskipun belum seluruhnya mencapai target maksimal 100%. Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi PPI telah terlaksana dengan cakupan yang luas dan menunjukkan peningkatan pengetahuan petugas, dibuktikan dengan peningkatan signifikan hasil post-test pelatihan PPI dasar.

Pengelolaan lingkungan, limbah, dan sterilisasi sudah berjalan sesuai standar, namun masih ditemukan ketidakkonsistenan perilaku petugas, terutama pada kepatuhan pemilahan sampah, penggunaan APD yang tepat, pengisian spill kit, serta kebersihan area kerja tertentu. Penginputan surveilans PPI di SIMRS belum optimal dan belum mencapai target 100%, menunjukkan perlunya penguatan sistem monitoring, penunjukan PIC yang jelas, serta pemanfaatan teknologi pengingat (reminder).

Kinerja SDM PPI, khususnya IPCLN dan anggota komite, secara umum berjalan baik, namun masih terdapat variasi kepatuhan dan tanggung jawab individu yang memerlukan pembinaan dan supervisi berkelanjutan. Secara keseluruhan, Komite PPI RS Prima Husada telah berperan aktif dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien, namun masih diperlukan penguatan budaya keselamatan dan konsistensi implementasi PPI di seluruh unit.

4.2 Saran / Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program PPI pada tahun berikutnya, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- Mempertahankan dan meningkatkan capaian surveilans HAIs, khususnya mempertahankan nol kasus VAP, IADP, ISK, dan dekubitus melalui audit bundle PPI yang lebih intensif dan analisis kasus jika terjadi peningkatan indikator.
- Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan dan penggunaan APD hingga mencapai target optimal dengan:
 - Penguatan supervisi rutin,
 - Edukasi ulang berbasis unit,
 - Pemberian umpan balik dan apresiasi kepada unit dengan kepatuhan terbaik.
- Menguatkan budaya disiplin dan tanggung jawab petugas, terutama dalam:
 - Pemilahan sampah,
 - Penanganan benda tajam,
 - Penyuntikan aman dan teknik aseptik,
 - Pengelolaan linen dan spill kit.
- Optimalisasi sistem surveilans berbasis SIMRS dengan:

- Penunjukan PIC PPI per unit,
- Penerapan reminder otomatis,
- Monitoring dan evaluasi rutin capaian penginputan,
- Pemberian pembinaan bagi unit dengan kepatuhan rendah.
- Penguatan kapasitas SDM PPI, khususnya IPCLN, melalui:
 - Pelatihan PPI lanjutan dan eksternal,
 - Penegasan uraian tugas dan tanggung jawab,
 - Evaluasi kinerja berkala yang terintegrasi dengan pembinaan.
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung PPI, antara lain:
 - Pemenuhan safety box sesuai standar,
 - Penyediaan area khusus pencucian ambulans,
 - Perbaikan fasilitas kebersihan tangan,
 - Penataan ruang dapur dan TPS B3 yang lebih optimal.
- Penguatan koordinasi lintas unit dan manajemen, agar program PPI tidak hanya menjadi tanggung jawab Komite PPI, tetapi menjadi budaya bersama seluruh anggota rumah sakit.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Prima Husada semakin meningkat serta risiko infeksi dapat ditekan secara berkelanjutan.

Mengetahui,
Ketua Komite PPI



dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Malang, 05 Januari 2026
Sekretaris Komite PPI/IPCN



Sherly Rosita, S. Kep. Ns

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

